

intersex
NIGERIA
CENTER FOR HEALTHCARE DEVELOPMENT & YOUTH EMPOWERMENT

# TROUSSE À OUTILS POUR DES SOINS DE SANTÉ ADAPTÉS AUX PERSONNES INTERSEXUÉES

*By Intersex Nigeria (Center for Healthcare Development and Youth Empowerment)*

© Intersex Nigeria (Center for Healthcare Development and Youth Empowerment).

Tous droits réservés.
Cette publication peut être utilisée à des fins de plaidoyer, de sensibilisation et d'éducation uniquement, à condition que le contenu ne soit pas modifié et que le nom d'Intersex Nigeria soit mentionné. Aucune partie de ce rapport ne peut être reproduite à des fins commerciales sans autorisation écrite préalable.

Pour toute autorisation ou demande de renseignements, veuillez contacter: info@intersexnigeria.org

## Informations de contact

Intersex Nigeria
(Center for Healthcare
Development and Youth
Empowerment)

Lagos and Abuja, Nigeria

info@intersexnigeria.org

+2349129057794

## Visitez notre site web

www.intersexnigeria.org

## Médias sociaux

@Intersex_nigeria_

@IntersexNigeria

@IntersexNigeria

Intersex Nigeria

Publiée: Intersex Nigeria Droits d'auteur: Intersex Nigeria, 2025

# À Propos D'intersex Nigeria

Intersex Nigeria est une organisation non gouvernementale dirigée par des personnes intersexuées, officiellement créée en 2019 et enregistrée au Nigeria en 2021. L'organisation est un symbole de soutien et d'autonomisation pour les personnes intersexuées au Nigeria. Bien qu'Intersex Nigeria soit basée au Nigeria, l'organisation mène des actions dans tout le pays et dans d'autres pays africains.

L'objectif principal de l'organisation est de défendre la santé sexuelle et reproductive, l'autodétermination, l'autonomie corporelle et les droits humains fondamentaux des personnes intersexuées à travers le Nigeria. Nous y parvenons grâce à une approche multiforme qui comprend le renforcement des communautés, le plaidoyer, la recherche fondée sur des preuves, les initiatives d'autonomisation et la diffusion de ressources éducatives sur les questions liées à l'intersexualité auprès de diverses parties prenantes, de partenaires et de la communauté au sens large. Cela implique de soutenir et d'autonomiser les personnes intersexuées et leurs familles par le biais de forums en ligne, d'activités sociales et de réunions en face à face ; de fournir des informations, des formations et des conseils sur les questions liées à l'intersexualité via Internet et des supports d'information, de communication et d'éducation ; de diriger et de contribuer aux processus d'élaboration des politiques qui protègent et fournissent des services de santé complets aux personnes intersexuées ; accroître le soutien, la sensibilisation et la reconnaissance des droits des personnes intersexuées grâce à l'engagement de différentes parties prenantes ; s'engager et établir des partenariats avec d'autres organisations qui partagent des objectifs communs ; et collecter, utiliser et canaliser des ressources pour soutenir le niveau de vie des personnes intersexuées tout en garantissant leur sécurité et leur développement durable.

Au cœur de notre vision se trouve le désir de voir une société où les personnes intersexuées, dès leur naissance, ont droit à l'intégrité physique et à l'autonomie et sont exemptes de stigmatisation et de discrimination. Nous envisageons un avenir où la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes intersexuées seront éradiquées et remplacées par une culture d'inclusion, de visibilité et de compréhension. Notre mission est claire : créer une société favorable qui promeut la visibilité, l'inclusion, l'autonomie corporelle, la santé sexuelle et reproductive, y compris le bien-être mental et les droits humains des personnes intersexuées au Nigeria, grâce à l'organisation communautaire, la recherche, le plaidoyer, l'autonomisation et l'engagement public dans une perspective féministe. Chez Intersex Nigeria, nous concevons tous nos projets en gardant cette mission à l'esprit. En fin de compte, notre objectif est de garantir que les personnes intersexuées au Nigeria, dès leur naissance et tout au long de leur vie, se voient accorder les droits fondamentaux à l'intégrité physique et à l'autonomie, libérées du joug de la stigmatisation et de la discrimination. Grâce à nos efforts inlassables, nous nous efforçons d'ouvrir la voie à un avenir où chaque personne intersexuée pourra s'épanouir, sans être entravée par les préjugés sociaux.

# Remerciements

Intersex Nigeria exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette « boîte à outils pour des soins de santé adaptés aux personnes intersexuées ». Cette initiative n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible, le dévouement et les idées de nombreuses personnes et organisations.

Nous remercions Doose Mchihi, consultant infatigable qui a travaillé sans relâche sur cette boîte à outils afin d'en faire une ressource solide, pour son engagement à veiller à ce que les personnes intersexuées ne soient pas laissées pour compte, ce qui transparaît clairement dans le travail qu'il accomplit auprès de la communauté. Nous remercions les personnes intersexuées qui ont partagé leurs expériences vécues avec courage et franchise de nous avoir fait confiance pour faire entendre leur voix. Vos récits ont été précieux pour façonner cette ressource afin qu'elle reflète la réalité authentique des personnes intersexuées.

Nous remercions également les professionnels de santé, les défenseurs et les experts qui ont donné de leur temps et partagé leurs connaissances pour garantir l'exactitude et la pertinence de cette boîte à outils. Votre engagement en faveur d'un système de santé plus inclusif est une source d'inspiration. Nous remercions tout particulièrement l'équipe des programmes d'Intersex Nigeria pour son travail acharné dans la conduite de ce projet, ainsi que notre partenaire Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) qui a soutenu ce projet. Votre expertise et votre collaboration ont considérablement enrichicet effort.

Avec toute notre gratitude,
Équipe Intersex Nigeria

# Table des Matières


**À PROPOS D'INTERSEX NIGERIA** I
**REMERCIEMENTS** II
**TABLE DES MATIÈRES** III

**1.0 INTRODUCTION** 01
1.1 Objectif du guide 01
1.2 Importance des soins de santé adaptés aux personnes intersexuées au Nigeria 01
1.3 Public cible 02
1.4 Comment utiliser le guide 02

**2.0 COMPRENDRE L'INTERSEXUALITÉ** 03
2.1 Définition des variations intersexuées 04
2.2 Diversité des personnes intersexuées 04
2.3 Variations intersexuées courantes et leurs caractéristiques 05
2.4 Prévalence des traits intersexués et diversité au sein de la population intersexuée 08
2.5 Autres questions fréquentes sur les variations intersexuées 09
2.6 Considérations psychologiques, médicales, sociales et culturelles 10
2.7 Dissiper les mythes et les idées fausses 11
2.8 Importance d'utiliser un langage respectueux et approprié 12
2.9 Évolution du langage et des concepts dans les soins aux personnes intersexuées. 13

**3.0 BESOINS EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ DES PERSONNES INTERSEXUÉES** 16
3.1 Considérations générales en matière de soins de santé 17

**4.0 INTERVENTIONS MÉDICALES ET CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES** 23
4.1 Historique des interventions médicales sur les personnes intersexuées 24
4.2 Implications éthiques des interventions chirurgicales et des traitements hormonaux 25
4.3 Approches alternatives et importance des soins centrés sur le patient 27

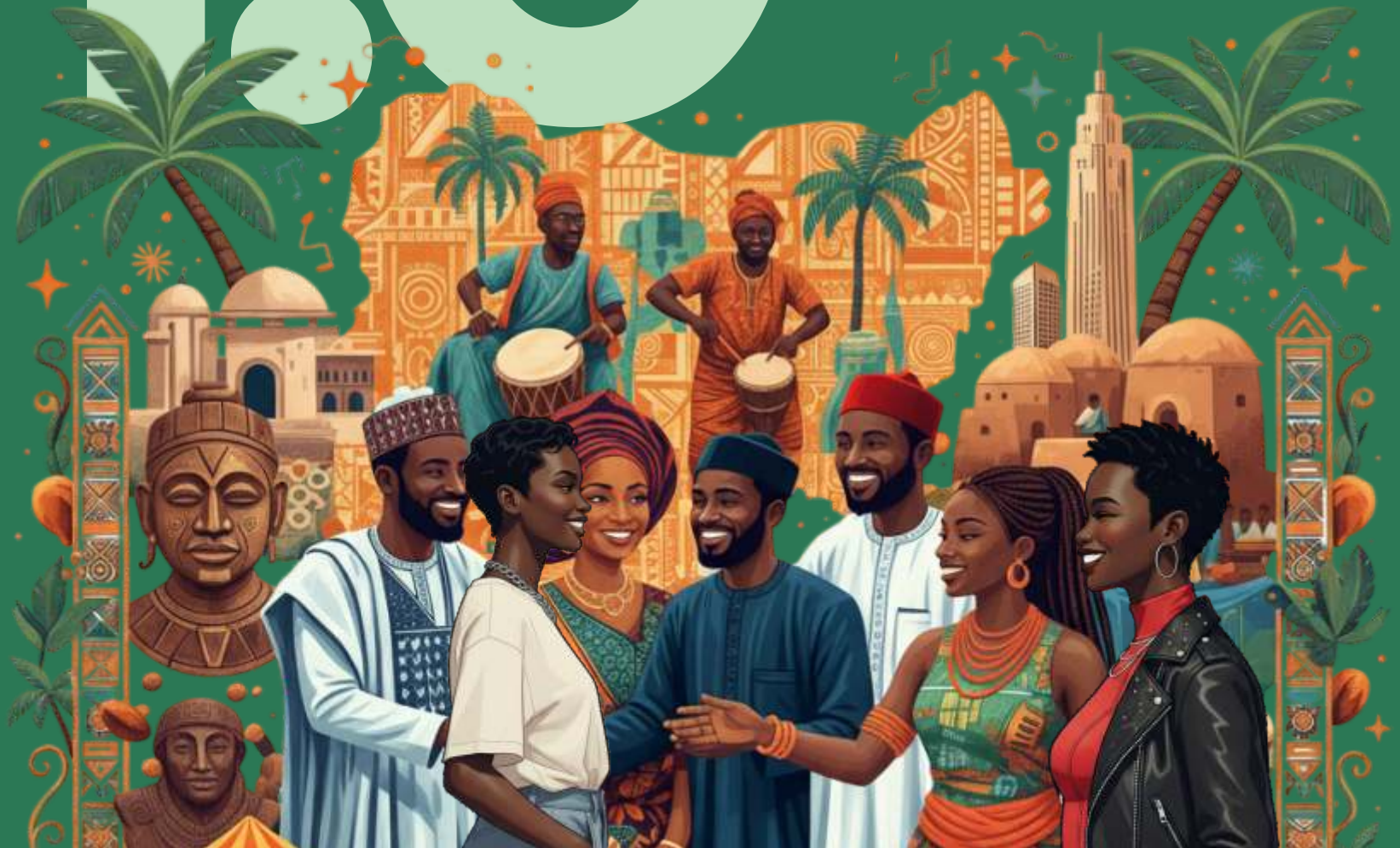
**5.0 CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE SOINS DE SANTÉ SOLIDAIRE ET INCLUSIF POUR LES PERSONNES INTERSEXUÉES** 29
5.1 Stratégies de communication 30
5.2 Formation des professionnels de santé 36
5.3 Confidentialité et vie privée 36

**6.0 COMPÉTENCE ET SENSIBILITÉ CULTURELLES** 42
6.1 Comprendre la diversité culturelle et son impact sur les soins de santé aux personnes intersexuées 43

**7.0 ÉTUDES DE CAS ET MEILLEURES PRATIQUES** 46
Études de cas 47

**8.0 APPEL À L'ACTION** 51
CONCLUSION 54

# 1.0 Introduction



# 1.0 Introduction

## 1.1 Objectif du guide

L'objectif du guide des soins de santé adaptés aux personnes intersexuées est de fournir aux professionnels de santé, aux décideurs politiques et aux organisations de la société civile (OSC) les informations, les stratégies et les directives morales dont ils ont besoin pour offrir aux personnes intersexuées des services et des interventions accueillants, respectueux et sensibles. Ses principaux objectifs sont les suivants:

**1. Éducation et sensibilisation:** sensibiliser les prestataires de soins de santé aux variations intersexuées et remettre en question les pratiques médicales dépassées qui privilégient la normalisation des corps intersexués au détriment de l'autonomie des patients.

**2. Interventions médicales éthiques:** promouvoir les meilleures pratiques en matière de soins centrés sur le patient, en mettant l'accent sur le consentement éclairé et l'autonomie corporelle avant toute intervention médicale, en particulier les chirurgies non urgentes sur les nourrissons et les enfants intersexués.

**3. Compétence culturelle:** favoriser la compréhension des dynamiques culturelles, en particulier dans des régions comme le Nigeria, et fournir des conseils pour mener des conversations sensibles avec les patients et leurs familles.

**4. Défense des droits et autonomisation:** doter les personnes intersexuées et leurs familles des outils nécessaires pour défendre leurs propres droits, afin qu'elles puissent naviguer dans les systèmes de santé avec confiance et dignité.

**5. Élaboration de politiques:** fournir des cadres pour l'élaboration de politiques de santé inclusives pour les personnes intersexuées, en aidant les établissements de santé à créer un environnement plus accueillant pour les patients intersexués et leurs familles

.

## 1.2 Importance des soins de santé adaptés aux personnes intersexuées au Nigeria

Au Nigeria, les personnes intersexuées sont confrontées à des défis importants, notamment la stigmatisation sociale, la médicalisation et le manque de sensibilisation. La pression sociale pour se conformer aux normes binaires de genre pousse de nombreuses personnes intersexuées à subir des interventions médicales inutiles sans leur consentement dès la naissance. Ce manque de compréhension et de respect de l'autonomie des personnes intersexuées entraîne des dommages physiques et psychologiques à long terme.

**Les soins de santé adaptés aux personnes intersexuées sont importants au Nigeria pour les raisons suivantes:**

1. **Réduit la stigmatisation**: en raison de leurs caractéristiques sexuelles variées, les personnes intersexuées sont souvent marginalisées. La création d'environnements de soins de santé inclusifs et sensibles à ces différences peut contribuer à réduire la stigmatisation sociale.

2. **Favorise le consentement éclairé:** sans leur consentement, les personnes intersexuées ont historiquement subi des chirurgies néfastes et irréversibles. Donner la priorité au consentement éclairé garantit que les personnes intersexuées contrôlent les décisions concernant leur corps.

3. **Lutte contre les barrières culturelles:** dans la société culturellement diversifiée du Nigeria, les croyances traditionnelles et religieuses sur le genre conduisent souvent à des malentendus à

l'égard des personnes intersexuées. Des soins de santé adaptés aux personnes intersexuées peuvent combler ces lacunes en éduquant les communautés et en fournissant des soins respectueux, conformes à la fois aux valeurs culturelles et aux droits humains.

4. **Améliore la santé mentale:** de nombreuses personnes intersexuées subissent des traumatismes dus à la discrimination et aux interventions médicales. Leur donner accès à des soins de santé adaptés, c'est reconnaître leur identité et leurs besoins, et cela peut améliorer leur santé mentale.

## 1.3 Public cible

**Le kit d'outils est destiné aux :**

- **Professionnels de santé:** médecins, infirmiers et professionnels de santé qui interagissent directement avec des patients intersexués. Il leur fournit les connaissances et les stratégies nécessaires pour prodiguer des soins non discriminatoires et éthiques.

- **Décideurs politiques:** responsables gouvernementaux et décideurs politiques dans le domaine de la santé qui peuvent influencer les systèmes de santé et les cadres juridiques afin de protéger les personnes intersexués.

- **Les leaders communautaires et les ONG:** les organisations œuvrant dans le domaine de la défense des soins de santé et des droits humains, qui peuvent utiliser la boîte à outils pour sensibiliser les communautés et faire pression en faveur de réformes politiques.

- Les **familles des personnes intersexuées**: les parents, les tuteurs et les familles peuvent utiliser cette boîte à outils pour mieux comprendre les variations intersexuées et défendre les droits et la santé de leurs proches.

## 1.4 Comment utiliser la boîte à outils

**1. Ressource éducative:** la boîte à outils sert de guide éducatif pour former les professionnels de santé afin qu'ils soient en mesure de traiter les questions de santé liées à l'intersexualité avec sensibilité et respect.

2. **Élaboration de politiques:** elle fournit des cadres aux établissements de santé et aux agences gouvernementales pour élaborer et mettre en œuvre des politiques inclusives envers les personnes intersexuées qui protègent les droits des patients.

3. **Outil de défense des droits:** les ONG et les groupes de défense des droits peuvent utiliser la boîte à outils pour militer en faveur de meilleurs services de santé, de protections juridiques et d'une meilleure compréhension des questions liées à l'intersexualité par la société.

**4. Soutien aux familles:** la boîte à outils fournit des ressources aux familles pour les aider à comprendre les variations intersexuées et à s'y retrouver dans les systèmes médicaux afin de garantir que les membres intersexués de leur famille reçoivent des soins appropriés.



# 2.0

# Comprendre L'intersexualité



# 2.0 Comprendre L'intersexualité

## 2.1 Définition des variations intersexuées

Les variations intersexuées désignent un large éventail de différences physiques naturelles dans les caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions binaires typiques de l'homme ou de la femme. Ces variations peuvent être évidentes à la naissance, pendant la puberté, ou parfois ne jamais être identifiées à moins qu'une personne ne subisse des tests médicaux. Elles peuvent concerner les chromosomes, les gonades (testicules ou ovaires), les hormones sexuelles ou les organes génitaux.

Il existe plus de 46 variations intersexuées différentes. Ces conditions se caractérisent par des différences dans les schémas chromosomiques, les organes génitaux externes et bien d'autres aspects. Les variations intersexuées peuvent affecter les personnes de manière différente, il n'y a donc pas d'expérience unique commune à toutes les personnes intersexuées.

## 2.2 Diversité des personnes intersexuées

Il est important de ne pas regrouper toutes les personnes intersexuées dans une nouvelle catégorie collective, telle que le "troisième sexe", qui pourrait être parallèle aux sexes féminin et masculin. Une telle classification serait incorrecte en raison de l'énorme diversité qui existe parmi les personnes intersexuées et du fait que beaucoup d'entre elles s'identifient comme femmes ou hommes, tandis que d'autres s'identifient comme les deux ou ni l'un ni l'autre. En effet, "intersexué" est un terme générique qui désigne les personnes présentant des « variations des caractéristiques sexuelles » plutôt qu'un type en soi. Cette diversité n'est pas propre aux personnes intersexuées, car, sans surprise, on trouve également toute une gamme de variations dans l'anatomie sexuelle des femmes et des hommes qui répondent aux normes médicales de leurs catégories respectives.

Le terme "hermaphrodite" était largement utilisé par les praticiens médicaux au cours des XVIIIe et XIXe siècles, avant que le terme « intersexué » ne soit inventé comme terme scientifique et médical au début du XXe siècle. Avant que la classification médicale actuelle des troubles du développement sexuel (DSD) ne soit élaborée, les variations des caractéristiques sexuelles intersexuées étaient classées dans différentes catégories, les plus courantes étant : l'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS), le syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA), la dysgénésie gonadique, l'hypospadias et les compositions chromosomiques inhabituelles telles que XXY (syndrome de Klinefelter) ou XO (syndrome de Turner). Les « hermaphrodites véritables » désignaient les personnes qui combinaient des ovaires et des testicules.

Il est important de noter que les variations des caractéristiques sexuelles sont différentes de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, même si ces trois aspects interagissent dans la formation de la personnalité d'une personne. La campagne « Free & Equal » du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) souligne que « les personnes intersexuées ont les mêmes orientations sexuelles et identités de genre que les personnes non intersexuées ». Dans cette optique, il est erroné de qualifier les personnes intersexuées d'« intersexuées », car les caractéristiques sexuelles intersexuées n'ont aucun rapport avec l'orientation sexuelle. De même, il est incorrect de parler d'« identité intersexuée », car l'intersexualité n'est pas nécessairement une question d'identité ou de perception de soi, mais fait principalement référence à des aspects innés/physiques du corps.

La plupart des discriminations à l'égard des personnes intersexuées sont motivées par l'homophobie et/ou la transphobie, qui relient leurs expériences à celles d'autres populations marginalisées ou d'autres groupes sexuels minoritaires.

Voici quelques exemples: « Le choix parental contre l'intersexualité peut dissimuler des préjugés contre l'attirance pour le même sexe et la non-conformité de genre.

Les rôles sexuels et de genre attribués par la société conduisent souvent à des violations des droits humains à l'encontre des minorités sexuelles. Cela est particulièrement vrai lorsque l'hétéronormativité et la conformité au sexe attribué à la naissance sont associées à des idées préconçues qui valorisent l'hétérosexualité. Les stéréotypes en matière de droits humains renforcent ces dichotomies en permettant aux femmes et aux hommes d'avoir des apparences et des rôles différents, et en imposant une distance juridique et/ou sociale entre eux.

D'autres groupes marginalisés, tels que les personnes handicapées et celles qui ont subi des mutilations ou des excisions génitales, partagent également certaines préoccupations en matière de droits humains avec les personnes intersexuées. Les personnes intersexuées peuvent trouver utile le cadre juridique bien établi qui protège les personnes handicapées, qui est très étendu dans plusieurs pays, pour protéger leurs droits ou servir de référence pour l'élaboration d'une législation spécifique aux personnes intersexuées.

En outre, il est important de reconnaître que la prévalence des personnes intersexuées n'est peut-être pas aussi rare qu'on le pense généralement. Si un expert d'un centre de santé est susceptible de citer un chiffre compris entre 1 sur 1 500 et 1 sur 2 000, sur la base d'une estimation du nombre de nouveau-nés diagnostiqués comme intersexués, de nombreuses personnes naissent avec des variations sexuelles plus subtiles qui ne sont pas immédiatement détectables. Ce dernier groupe, cependant, ne répond toujours pas aux normes médicales féminines et masculines et peut être soumis à des interventions médicales à un stade ultérieur. Dans ses recherches sur la littérature médicale pour estimer la fréquence, Anne Fausto-Sterling a conclu qu'environ 1.7% des naissances humaines sont intersexuées.[1]

## 2.3 Variations intersexuées courantes et leurs caractéristiques

Selon l'organisation de défense des personnes intersexuées interACT, il existe plus de 46 termes définis pour désigner différentes variations intersexuées.[2]

**Voici quelques exemples de ces variations:**

**46, XX Hyperplasie congénitale des surrénales avec perte de sel (SWCAH)**

Un bébé avec des chromosomes XX et une CAH a généralement un utérus, des ovaires et des organes génitaux qui peuvent sembler visuellement différents. Cela peut inclure un clitoris de grande taille, un vagin court et/ou des lèvres plus grandes ou différentes. Les bébés atteints d'autres types de CAH peuvent ne pas présenter de différence génitale.

Bien que les différences génitales en elles-mêmes ne mettent presque jamais la vie en danger, les nourrissons atteints de CAH ont également des besoins médicaux importants en raison de la façon dont leur corps produit des hormones de stress. Le CAH avec perte de sel (SWCAH) 46, XX survient lorsqu'il y a une mutation génétique dans les enzymes de la glande surrénale, située au-dessus des reins. Ces enzymes sont des substances chimiques dont la glande surrénale a besoin pour transformer le cholestérol en trois hormones importantes qui aident à réguler les fonctions de

l'organisme : le cortisol, l'aldostérone et l'androgène. Si l'une des enzymes nécessaires à la production de cortisol et/ou d'aldostérone ne fonctionne pas correctement, les glandes surrénales ne fonctionnent pas de manière équilibrée. Elles produisent trop peu de cortisol et/ou d'aldostérone et plus d'androgènes que d'habitude. Lorsqu'il n'y a pas assez de cortisol ou d'aldostérone, les bébés atteints de SW CAH peuvent tomber gravement malades. Ils peuvent se déshydrater et perdre leur pression artérielle s'ils ne sont pas traités d'urgence.

**Syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA)**
Le SIA survient lorsque les bébés naissent avec des testicules et des chromosomes XY, mais que leur corps est immunisé ou incapable de répondre aux androgènes, une catégorie d'hormones comprenant la testostérone. Étant donné que le pénis et le scrotum se développent sous l'influence des androgènes, un bébé atteint de SIA peut présenter des différences génitales, en fonction de son niveau d'immunité aux androgènes.

**Les bébés atteints d'AIS complet (CAIS**) ne réagissent pas aux androgènes et développent généralement une vulve et un clitoris de taille normale, tandis que les bébés atteints d'AIS partiel (PAIS) peuvent présenter des différences génitales, avec des organes génitaux externes qui apparaissent sur un spectre. Au cours du développement, les testicules produisent également une hormone (substance inhibitrice de Müller, ou MIS) qui empêche la formation de l'utérus, des trompes de Fallope et d'une petite partie du vagin supérieur. Les enfants présentant des testicules et une sensibilité moindre, ou une capacité moindre à répondre aux androgènes, peuvent passer par une puberté féminisante de manière spontanée.

[1] *https://rm.coe.int/16806da5d4*
[2] *https://interactadvocates.org/intersex-definitions/*

Comme les testicules produisent une certaine quantité d'œstrogènes et que le corps peut transformer les androgènes en œstrogènes, ces enfants peuvent présenter des caractéristiques telles que le développement des seins sous l'effet de leurs propres hormones à la puberté et complètent souvent cela par des hormones synthétiques pour se développer pleinement. L'ablation chirurgicale des testicules (gonadectomie) peut être recommandée dans le cas du PAIS, car il existe un risque de développement d'un cancer des testicules. Le risque de développement d'un cancer avant la puberté dans le cas du CAIS est très faible, et il est courant dans la pratique médicale de laisser les testicules CAIS en place pour une puberté plus naturelle. Comme les androgènes influencent également la formation des spermatozoïdes, certains hommes adultes ne découvrent qu'ils sont atteints d'un PAIS minimal qu'après avoir consulté un médecin pour des tests de fertilité.

**46, XY dysgénésie gonadique complète (syndrome de Swyer)**
Le syndrome de Swyer survient lorsqu'un bébé naît avec des chromosomes XY, mais que les testicules ne se développent pas. Au cours du développement prénatal, ces bébés développent une vulve et un petit utérus. Les « testicules en devenir » sous-développés deviennent un tissu fibreux appelé « stries », qui n'est ni un testicule ni un ovaire. Ces enfants doivent prendre des hormones pour commencer la puberté. En raison du risque accru de cancer dans les gonades striées, leur ablation est généralement recommandée.

**46, XY dysgénésie gonadique partielle**
La dysgénésie gonadique partielle chez un bébé avec des chromosomes XY entraîne le développement de testicules qui ne fonctionnent pas au même niveau que les testicules typiques. Parfois, les testicules disparaissent ou régressent. L'apparence des organes génitaux des bébés peut varier en fonction du fonctionnement des testicules. Des tumeurs apparaissent dans environ 20 à 30 % des cas.

Déficit en 5-alpha réductase-3 (déficit en 5 ARD) et déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase-3 (déficit en 17 BHSD) Dans le déficit en 5-alpha réductase-3 (déficit en 5 ARD) et le déficit en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase-3 (déficit en 17 BHSD), des mutations génétiques chez les bébés XY avec testicules entraînent des taux atypiques d'hormones sexuelles. Toutes les hormones sont produites à partir du cholestérol par des enzymes, et ces mutations modifient la fonction des enzymes nécessaires à la production d'androgènes. Les enfants atteints d'un déficit en 5 ARD et d'un déficit en 17 BHSD ont des chromosomes XY et des testicules, mais leurs testicules produisent une version de l'androgène plus faible que la normale. Les bébés peuvent avoir une vulve ou présenter des différences génitales plus ou moins marquées. À la puberté, lorsque les niveaux d'androgènes augmentent considérablement, la grande quantité d'androgènes plus faibles peut entraîner des changements tels que l'approfondissement de la voix, la pousse de poils sur le visage et le développement musculaire. Si un enfant ne souhaite pas ces changements, la puberté peut être bloquée par des médicaments. Des cas de fertilité chez des adultes atteints d'un déficit en 5 ARD ont été rapportés, mais pas chez ceux atteints d'un déficit en 17 BHSD.

**DSD ovotesticulaire**

Dans le développement sexuel typique, le fœtus développe deux petits organes appelés « protogonades ». Généralement, ces protogonades deviennent soit des testicules, soit des ovaires. Parfois, un ovotestis se développe à la place, qui contient des cellules de type ovarien et des cellules de type testiculaire. Bien qu'une personne puisse naître avec deux ovotestes, il est beaucoup plus fréquent qu'une personne naisse avec un ovaire ou un testicule typique d'un côté et un ovotestis de l'autre. Les personnes atteintes d'ovotestes peuvent avoir une apparence génitale typique à la naissance, avec soit une vulve et des lèvres, soit un pénis et un scrotum, et certaines ont une apparence intermédiaire. Comme il peut y avoir de nombreuses combinaisons chromosomiques et anatomiques internes différentes, les enfants peuvent avoir besoin d'autres tests pour évaluer leur situation particulière. La partie testiculaire des ovotestes peut présenter un risque accru de cancer.

**Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH)**

Les enfants présentant 46 chromosomes XX et des ovaires peuvent avoir un développement atypique des structures internes telles que le vagin, l'utérus et les trompes de Fallope. Le syndrome MRKH s'accompagne parfois de différences dans le développement du squelette, des oreilles internes et, dans des cas plus rares, du cœur, des doigts et des orteils.

**Hypospadias et épispadias**

L'hypospadias se produit lorsque l'ouverture urinaire (urètre) est située en dessous de la position habituelle à l'extrémité du pénis. Il s'agit de l'une des variations génitales les plus courantes et les plus visibles. L'hypospadias est la différence congénitale la plus courante chez les enfants ayant des chromosomes XY, observée chez 1 naissance vivante sur 125 à 300. La cause de l'hypospadias n'est pas connue. L'emplacement de l'ouverture de l'urètre peut varier de juste en dessous de l'extrémité du pénis jusqu'à juste devant le rectum. Une courbure du pénis, ou chordee, est souvent observée avec l'hypospadias, bien qu'elle puisse se produire séparément.

L'épispadias est similaire à l'hypospadias car l'ouverture urinaire n'est pas à sa position habituelle. Dans l'épispadias, l'ouverture urinaire est située sur la face supérieure du pénis ou au milieu du clitoris. Il est beaucoup moins fréquent que l'hypospadias. L'épispadias survient généralement dans des conditions appelées extrophie, où la vessie, la paroi abdominale et le bassin ne sont pas fermés à l'avant comme d'habitude, mais l'épispadias peut également se produire seul.

**Syndrome de Turner (TS) X0**
Le syndrome de Turner survient lorsqu'une personne possède un chromosome X complet et que son deuxième chromosome X est absent ou plus petit que la normale. Cela se produit chez environ 1 naissance vivante sur 2 000. Le syndrome de Turner est parfois détecté avant la naissance grâce à l'amniocentèse. Dans le ST, le niveau d'hormones nécessaire pour déclencher la puberté est anormalement bas en raison d'une différence dans le développement des ovaires, appelés « gonades striées ». Le ST peut également être découvert à l'adolescence lorsque la puberté ne se déroule pas comme prévu. De nombreuses personnes atteintes du ST sont de petite taille, souvent moins d'1,50 mètre. D'autres organes du corps, tels que le cœur, peuvent également se développer de manière atypique.

Certaines personnes n'ont qu'un seul chromosome X dans certaines de leurs cellules. C'est ce qu'on appelle le « syndrome de Turner mosaïque ». Les autres cellules peuvent avoir des chromosomes XX ou XY. Les différences physiques dans le syndrome de Turner mosaïque dépendront de la proportion de cellules et de tissus ayant des chromosomes XX ou XY typiques.

**Syndrome de Klinefelter XXY**
Le syndrome de Klinefelter (ou syndrome XXY) est une maladie génétique dans laquelle une personne possède une copie supplémentaire du chromosome X. Le syndrome de Klinefelter n'est pas héréditaire, mais résulte plutôt d'une erreur génétique aléatoire après la conception. Les personnes nées avec le syndrome de Klinefelter peuvent présenter un faible taux de testostérone et une masse musculaire, une pilosité faciale et une pilosité corporelle réduites. La plupart des personnes atteintes de cette maladie produisent peu ou pas de spermatozoïdes. Certaines peuvent opter pour un traitement de substitution à la testostérone et un traitement de fertilité.[3]

## 2.4 Prévalence des caractéristiques intersexuées et diversité au sein de la population intersexuée

Les personnes intersexuées naissent avec des variations des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques des corps masculins ou féminins. La diversité au sein de la population intersexuée est grande ; elle englobe un large éventail de variations chromosomiques, hormonales et anatomiques. Il est important de noter que l'intersexualité n'est pas une variation unique, mais plutôt un terme générique désignant un certain nombre de différences dans le développement sexuel (DSD). Dans certains cas, les différences intersexuées sont apparentes à la naissance, tandis que dans d'autres, elles ne peuvent être identifiées qu'à la puberté ou même plus tard dans la vie, et certaines peuvent ne jamais être découvertes au cours de la vie. Les variations intersexuées sont incroyablement diverses.

**Voici quelques exemples de variations chromosomiques, hormonales et anatomiques:**

**Variations chromosomiques:** les individus peuvent présenter des schémas chromosomiques atypiques tels que:

- Le syndrome de Klinefelter (XXY), où les individus ont un chromosome X supplémentaire.

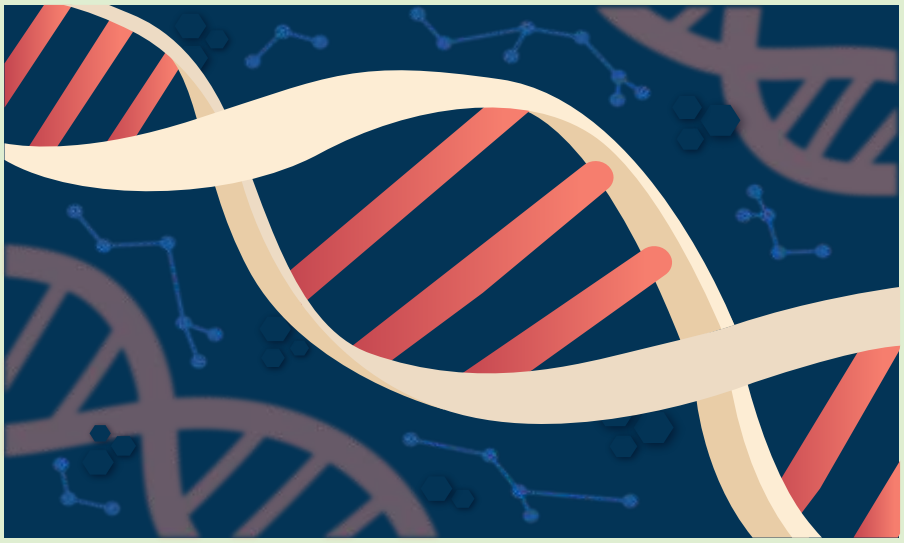
[3] *https://interactadvocates.org/intersex-definitions/*

- Syndrome d'insensibilité aux androgènes (AIS), où une personne avec des chromosomes XY a des tissus corporels qui ne réagissent pas à la testostérone.

- Syndrome de Turner (XO), où les personnes peuvent n'avoir qu'un seul chromosome X ou un deuxième chromosome partiel.

**Variations hormonales:** Certaines personnes peuvent avoir des chromosomes masculins ou féminins typiques, mais une production ou une réception hormonale atypique, ce qui entraîne des différences de développement. Par exemple:

- L'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS), qui affecte la production de cortisol et d'androgènes, entraîne souvent une ambiguïté génitale chez les personnes ayant des chromosomes XX.



- Le déficit en 5-alpha-réductase, où les personnes ayant des chromosomes XY ont une forme de testostérone qui ne se convertit pas correctement, ce qui entraîne souvent une ambiguïté génitale ou une apparence féminine à la naissance.

**Variations anatomiques:** Certaines caractéristiques intersexuées sont visibles à la naissance sous la forme d'organes génitaux ambigus, tandis que d'autres peuvent concerner des organes reproducteurs internes qui ne correspondent pas aux organes génitaux externes. Cela peut inclure les personnes présentant des ovotestes (tissu ovarien et testiculaire) ou des gonades atypiques.

## 2.5 Autres questions fréquentes sur les variations intersexuées

Les variations intersexuées peuvent affecter différemment les personnes intersexuées, et il n'existe pas d'expérience intersexuée "unique". Que vous ayez récemment appris que vous êtes intersexué ou que vous soyez simplement curieux d'en savoir plus sur ce que signifie être intersexué, voici quelques informations supplémentaires que vous devriez connaître.

**Quelle est la forme d'intersexualité la plus rare?**
Selon Özdemir Meltem et Co.[4], la forme la plus rare de variation intersexuée est le DSD ovotesticulaire, également appelé ovotestes. Le DSD ovotesticulaire était auparavant connu sous le nom de "véritable hermaphrodisme", mais les personnes intersexuées ont choisi de ne plus utiliser ce terme, car il est devenu stigmatisant.

**Peut-on être intersexué sans le savoir?**
Oui. Les traits intersexués peuvent varier d'une personne à l'autre, et toutes les personnes intersexuées ne présentent pas nécessairement des changements visibles dans leurs caractéristiques sexuelles. Certaines personnes peuvent ne jamais savoir qu'elles sont intersexuées, tandis que d'autres le découvrent plus tard dans leur vie à travers des expériences personnelles ou des tests médicaux.

**Les personnes intersexuées ont-elles leurs règles?**
Plusieurs facteurs peuvent influencer le fait que les personnes intersexuées aient ou non leurs règles, indépendamment de leur identité de genre. Les variations intersexuées affectent différentes caractéristiques sexuelles et, en fin de compte, le fait qu'une personne intersexuée ait ou non ses règles dépendra de la manière dont ses caractéristiques intersexuées affectent son corps.

**Quelle est la différence entre intersexué et hermaphrodite?**
"Hermaphrodite" est un terme désuet et trompeur que les professionnels de la santé utilisaient auparavant pour décrire les personnes présentant des variations intersexuées. De nombreuses personnes intersexuées considèrent le terme « hermaphrodite » comme une insulte et préfèrent utiliser le terme « intersexué » pour se décrire et décrire leurs expériences.

**Être intersexué, c'est la même chose qu'être transgenre?**
Non. Bien que le sexe et le genre soient liés, ils ne sont pas identiques.
Cependant, certaines personnes intersexuées peuvent également être transgenres, selon la manière dont leurs sentiments correspondent au genre dans lequel elles ont été élevées. Il est également possible que la conception qu'une personne intersexuée a de son genre change si son corps subit des transformations inattendues pendant la puberté.

**Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) peut-il être considéré comme une variation intersexuée?**
La réponse à cette question fait encore l'objet d'une vive controverse parmi les experts médicaux et la communauté intersexuée. Actuellement, le SOPK n'est pas considéré médicalement comme une variation intersexuée. Mais de nombreuses personnes atteintes du SOPK connaissent des changements de type intersexué au niveau de leur équilibre hormonal, de leurs organes génitaux, de leurs caractéristiques sexuelles secondaires, etc.

[4] *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6737443/*

## 2.6 Considérations psychologiques, médicales, sociales et culturelles

Les expériences des personnes intersexuées sont façonnées non seulement par leurs caractéristiques biologiques, mais aussi par des croyances profondément enracinées et des aspects tels que les attitudes psychologiques, sociales, culturelles et médicales. Historiquement, de nombreuses personnes intersexuées ont été soumises à des interventions médicales non consenties, notamment des opérations chirurgicales et des traitements hormonaux visant à conformer leur corps aux normes binaires de genre. Ces pratiques ont été largement condamnées par les organisations de défense des droits humains, y compris les Nations unies, comme une violation de l'autonomie corporelle.

De nombreuses personnes intersexuées au Nigeria et en Afrique en général sont victimes d'une stigmatisation sévère et souffrent d'un manque d'estime de soi en raison de la compréhension limitée des variations intersexuées. Les enfants et les personnes intersexuées sont constamment perçus comme différents ou tabous en raison de leur corps, ce qui a un impact négatif sur leur bien-être psychologique et leur estime de soi. Au Nigeria, de nombreuses variations intersexuées sont considérées à travers le prisme de la superstition ou des croyances religieuses qui considèrent les personnes intersexuées comme maudites ou anormales. Les relations sont souvent compliquées par les attentes de la société et la peur de la divulgation. La plupart des personnes intersexuées évitent de nouer et d'entretenir des relations étroites par crainte d'être rejetées, jugées ou discriminées une fois que leur statut intersexué est connu. Au Nigeria, la plupart des familles de personnes intersexuées cachent l'existence de leur enfant ou frère ou sœur intersexué(e) afin d'éviter les jugements de la société. La pression pour maintenir le secret autour des enfants intersexués est forte, ce qui empêche souvent l'accès aux soins médicaux et psychologiques nécessaires.

> *Il existe un mouvement croissant en faveur des droits des personnes intersexuées au Nigeria, avec Intersex Nigeria qui milite pour la visibilité et la sensibilisation depuis 2019, ainsi que dans d'autres pays africains, en mettant l'accent sur la promotion de la défense des personnes intersexuées, l'autonomie corporelle, le consentement éclairé, la reconnaissance juridique et le droit à l'auto-identification. Les personnes intersexuées, comme tout autre groupe, ont un large éventail d'identités et d'expressions de genre, et de nombreux militants plaident également en faveur d'une plus grande sensibilisation au spectre intersexué.*
>
> *Pour être efficace, la défense des droits des personnes intersexuées au Nigeria doit tenir compte des spécificités culturelles et contextuelles, en tenant compte des dynamiques socioculturelles propres à chaque culture et zone géopolitique. La population intersexuée est diversifiée en termes de biologie, d'identité et d'expérience. Grâce à un travail de sensibilisation continu, la société nigériane reconnaît peu à peu la nécessité d'adopter des approches inclusives qui respectent les droits des personnes intersexuées à l'intégrité physique et à l'autodétermination.*

## 2.7 Dissiper les mythes et les idées reçues

**Mythe:** L'intersexualité est extrêmement rare.

**Réalité:** Le consensus scientifique est qu'entre 1,5 et 2 % de la population mondiale est intersexuée.

**Myth:** L'intersexualité est une condition qui doit être « corrigée ».

**Réalité:** Les personnes intersexuées, y compris les enfants, sont rarement affectées par leurs divergences naturelles, et un « traitement » inutile peut causer des dommages irréversibles à une personne intersexuée.

**Mythe:** Les personnes intersexuées ont « les deux » organes génitaux ou sont « des deux » sexes.

**Réalité:** En vérité, c'est plus compliqué que cela. Le sexe est une série de traits et de spectres, et le corps humain peut se développer de nombreuses façons. Avoir à la fois un pénis et un vagin n'en fait pas partie.

**Mythe:** Toutes les personnes intersexuées ont des organes génitaux ambigus à la naissance et ont besoin d'une intervention chirurgicale.

**Réalité:** Toutes les personnes intersexuées n'ont pas des organes génitaux ambigus à la naissance, toutes les expériences intersexuées n'impliquent pas une intervention chirurgicale et tous les dommages médicaux intersexués ne sont pas chirurgicaux. De nombreuses personnes intersexuées découvrent leur intersexualité à travers des différences hormonales pendant la puberté ou à l'âge adulte.

**Mythe:** Les personnes intersexuées sont transgenres.

**Réalité:** Le mot « transgenre » ou « trans » est un terme générique qui désigne les personnes don't l'identité de genre est différente du sexe qui leur a été attribué à la naissance. Le mot « intersexué » fait référence aux caractéristiques sexuelles innées/physiques et non à un sentiment d'identité interne.

**Mythe:** Les personnes intersexuées ont toutes un genre non binaire.

**Réalité:** Les personnes intersexuées peuvent avoir n'importe quel genre.

**Mythe:** Les personnes intersexuées ne peuvent pas avoir de relations sexuelles, tomber enceintes ou avoir des enfants.

**Réalité:** De nombreuses variations intersexuées correspondent à une anatomie reproductive interne typique. Chaque personne est différente. Certaines personnes intersexuées peuvent porter des enfants et produire du sperme. D'autres ne le peuvent pas. Certaines personnes intersexuées découvrent qu'elles ont à la fois des tissus ovariens et testiculaires après avoir donné naissance.



**Mythe :** personne ne défend les personnes intersexuées.

**Réalité:** bien qu'il existe encore de nombreuses idées fausses sur la signification du terme “intersexué”, il existe de nombreux militants intersexués extraordinaires à travers le monde qui se battent pour sensibiliser le public et protéger les droits humains.

## 2.8 Importance d'utiliser un langage respectueux et approprié

Le langage a le pouvoir soit d'affirmer l'humanité des personnes intersexuées, soit de perpétuer la stigmatisation, la discrimination et les traumatismes. La manière dont les prestataires de soins de santé communiquent avec leurs patients peut avoir un impact profond sur la qualité des soins et l'expérience globale de ces derniers. Il en va de même pour les personnes intersexuées : on ne saurait trop insister sur l'importance d'utiliser un langage respectueux, inclusif et approprié dans les établissements de santé. Au Nigeria, où les rôles traditionnels liés au genre sont strictement appliqués et où la sensibilisation aux variations intersexuées est faible, les établissements de santé deviennent souvent des lieux où les personnes intersexuées sont victimes de discrimination, d'incompréhension et parfois de traumatismes.

L'utilisation d'un langage sensible, respectueux et éclairé dans les soins de santé destinés aux personnes intersexuées contribue à lutter contre la stigmatisation médicale, évite la pathologisation, renforce la confiance entre les prestataires de soins de santé et les patients intersexués, et favorise l'autonomie corporelle et le consentement éclairé. Au Nigeria, les professionnels de santé ne bénéficient pas d'une formation complète sur les variations intersexuées. En raison de cette lacune, l'utilisation d'un langage préjudiciable et dépassé, tel que « hermaphrodite », est courante. Ce terme est péjoratif, médicalement inexact et offensant pour les personnes intersexuées et leurs droits humains. L'utilisation de termes stigmatisants qui déshumanisent les personnes intersexuées renforce les mythes sociétaux selon lesquels les corps intersexués sont contre nature ou doivent être « corrigés ». Un langage respectueux et inclusif, consistant par exemple à désigner les variations intersexuées simplement comme des « variations sexuelles », contribue à lutter contre la stigmatisation médicale et présente les caractéristiques intersexuées comme faisant partie de la diversité naturelle du corps humain.

Une étude récente menée par Intersex Nigeria a montré que dans le système de santé nigérian, les familles et les personnes intersexuées subissent souvent des pressions pour subir des interventions médicales visant à corriger leurs caractéristiques intersexuées, le plus souvent sans le consentement éclairé du patient. Ces interventions médicales sont souvent motivées par le malaise de la société face à des corps qui ne se conforment pas aux normes binaires de genre. Pour la plupart des personnes intersexuées, les établissements de santé sont des lieux de traumatismes importants en raison d'expériences passées de procédures non consenties, de diagnostics erronés ou de discrimination pure et simple. L'utilisation d'un langage respectueux et affirmatif est la première étape pour rétablir la confiance brisée entre les patients intersexués et les prestataires de soins de santé et pour faire évoluer l'approche des soins de santé, passant d'interventions coercitives à une approche qui permet aux personnes intersexuées de prendre leurs propres décisions éclairées concernant leur corps.

Un langage irrespectueux et une mauvaise identification du genre peuvent rendre difficile la pleine participation des personnes à nos communautés et à nos services. Nous nous trompons souvent de genre sans même nous en rendre compte, et nous ne réalisons souvent pas à quel point nos mots peuvent exclure certaines personnes. Ceux qui sont fréquemment victimes d'erreurs de genre par les autres restent silencieux, malgré la détresse importante que cela peut leur causer. Certaines personnes mettent plus de temps que d'autres à apprendre à utiliser un langage inclusif. Nous pouvons poliment et systématiquement donner l'exemple d'un langage respectueux et inclusif ou clarifier le langage préféré d'une personne auprès des autres. En nous exprimant et en donnant l'exemple d'une pratique inclusive, nous pouvons nous assurer que chacun d'entre nous a son mot à dire dans nos communautés et nos services [5].

Lorsque vous vous trompez sur le genre d'une personne, excusez-vous et commencez à utiliser un langage respectueux et neutre. À ce moment-là, une discussion prolongée sur l'erreur de genre risque de rendre la personne qui a été victime de cette erreur encore plus mal à l'aise. Après être parti, vous pouvez réfléchir à la manière d'être plus inclusif.

[5] *https://www.parliament.nsw.gov.au/lcdocs/other/12075/Inclusive%20language%20guide%20-%20Respecting%20people%20of%20intersex,%20trans%20and%20gender%20diverse%20experience.pdf*

## 2.9 Évolution du langage et des concepts dans les soins aux personnes intersexuées.



Les soins aux personnes intersexuées ont longtemps été envisagés dans un contexte de médicalisation, souvent motivé par la nécessité de corriger les corps qui s'écartent des normes binaires de genre. Au cours des dernières décennies, le langage et les concepts entourant les soins aux personnes intersexuées ont évolué et reflètent désormais une compréhension croissante de la diversité humaine et une transition vers des approches centrées sur le patient et fondées sur les droits. Cette évolution a été largement impulsée par les défenseurs des personnes intersexuées, les organisations de défense des droits humains et les professionnels de santé progressistes qui reconnaissent la nécessité de dépasser les pratiques dépassées fondées sur la stigmatisation et les interventions médicales non consenties, ces dernières constituant encore un énorme combat dans le contexte nigérian.

À mesure que le mouvement intersexué mondial et africain continue de croître et de gagner en visibilité, les professionnels de santé, les décideurs politiques et les communautés adoptent de plus en plus un langage et des cadres plus inclusifs et respectueux qui privilégient le bien-être et l'autonomie des personnes intersexuées. Ce changement est non seulement nécessaire pour améliorer la qualité des soins prodigués aux patients intersexués, mais aussi pour favoriser une acceptation plus large de la diversité corporelle par la société[6].

**Ancienne terminologie: pathologie et médicalisation:**

- “Troubles du développement sexuel (TDS)”: ce terme a été introduit au début des années 2000 afin de remplacer le terme “hermaphrodite”, considéré comme dépassé et offensant. Bien que le terme “TDS” constituait une amélioration, il continuait à présenter les caractéristiques intersexuées comme des troubles, contribuant ainsi à une vision médicalisée des corps intersexués comme des problèmes à corriger.

- **“Organes génitaux anormaux” ou “organes génitaux ambigus”:** ces termes étaient couramment utilisés dans le milieu médical pour décrire les caractéristiques intersexuées, renforçant ainsi l'idée que les corps intersexués étaient des déviations par rapport à la norme et devaient être modifiés chirurgicalement pour se conformer aux attentes sociétales en matière d'anatomie masculine ou féminine.

**Évolution de la terminologie : diversité et variation naturelle**
À mesure que la compréhension des corps et des expériences intersexués s'est développée, un nouveau langage est apparu, qui reflète le respect de la diversité corporelle et s'éloigne de la pathologisation des caractéristiques intersexuées:

- **"Différences dans le développement sexuel (DSD)":** bien que certains continuent d'utiliser ce terme, il a été reformulé par les défenseurs et les professionnels de la santé afin de mettre l'accent sur la diversité plutôt que sur le trouble. Par exemple, certains préfèrent le terme "variations du développement sexuel", qui évite les connotations négatives du mot "trouble".

- **"Traits intersexués" ou "variations sexuelles":** ces termes soulignent que les caractéristiques intersexuées sont des variations naturelles du développement humain, plutôt que des anomalies nécessitant une correction. En mettant l'accent sur la diversité des corps plutôt que sur des catégories médicalisées, ces termes favorisent une vision plus inclusive et plus tolérante des personnes intersexuées.

- **Organes génitaux "atypiques" ou "divers":** ces termes remplacent un langage plus ancien et plus stigmatisant en reconnaissant que les corps se présentent naturellement sous de nombreuses formes, qui sont toutes valables.

  Ce changement linguistique, passant de "troubles" à "variations", est essentiel pour changer la façon don't les personnes intersexuées sont perçues tant dans le milieu médical que dans la société en général. En mettant l'accent sur la diversité et en normalisant les traits intersexués, les professionnels de santé peuvent contribuer à réduire la stigmatisation qui est depuis longtemps associée aux corps intersexués.

**Des interventions forcées à l'autonomie corporelle**
Dans le passé, les soins prodigués aux personnes intersexuées se caractérisaient par des interventions médicales précoces et souvent irréversibles, en particulier des opérations chirurgicales visant à conformer les corps intersexués aux normes binaires masculines ou féminines. Ces opérations étaient généralement pratiquées sur des nourrissons ou de jeunes enfants, bien avant qu'ils ne soient en mesure de donner leur consentement ou de comprendre les implications de telles procédures. L'hypothèse sous-jacente était que ces opérations étaient nécessaires pour garantir que les enfants intersexués puissent "s'intégrer" socialement et psychologiquement.

**Anciens concepts : urgence et correction**

- **"Interventions chirurgicales de normalisation":** ces interventions étaient présentées comme nécessaires pour aider les personnes intersexuées à mener une vie « normale ». Le terme « normalisation » impliquait que les caractéristiques intersexuées étaient intrinsèquement problématiques et qu'une intervention médicale était nécessaire pour rendre une personne "normale".

- **"Chirurgies d'assignation de genre":** ces chirurgies étaient pratiquées pour assigner un genre aux nourrissons intersexués, souvent sur la base de l'apparence des organes génitaux externes. L'hypothèse était qu'il fallait assigner un genre le plus tôt possible pour éviter toute confusion et que la chirurgie était le meilleur moyen d'y parvenir.

**Concepts en évolution : autonomie et consentement éclairé**
Le plaidoyer des personnes et des organisations intersexuées a conduit à repenser ces pratiques, en mettant désormais l'accent sur le respect de l'autonomie corporelle et en veillant à ce que toute intervention médicale soit fondée sur le consentement éclairé.

[6] *https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2019/05/Protecting_intersex_in_Europe_toolkit.pdf*

- **“Autonomie corporelle”:** ce concept est au cœur de l'évolution de la compréhension des soins aux personnes intersexuées. L'autonomie corporelle souligne que les personnes intersexuées ont le droit de prendre des décisions concernant leur propre corps, y compris celle de subir ou non des interventions médicales. Plutôt que de se précipiter pour opérer les nourrissons, les professionnels de santé reconnaissent de plus en plus l'importance de laisser les personnes grandir et faire des choix éclairés concernant leur corps.

- **“Soins centrés sur le patient”:** contrairement aux anciens modèles de soins aux personnes intersexuées, qui privilégiaient la conformité aux normes sociales, les soins centrés sur le patient se concentrent sur les besoins, les préférences et le bien-être de l'individu. Cette approche consiste à travailler avec les patients intersexués (et leurs familles) pour leur fournir des informations, un soutien et des options sans les pousser à prendre des décisions pour lesquelles ils ne sont pas prêts.

- **“Consentement éclairé”:** pierre angulaire des soins modernes aux personnes intersexuées, le consentement éclairé garantit que les personnes intersexuées (ou leurs familles, le cas échéant) ont accès à des informations complètes et précises sur leurs options médicales et sur les risques et avantages potentiels des différentes interventions. Ce concept donne la priorité au droit des patients de comprendre leur différence et de participer aux décisions concernant leurs soins.



# 3.0

# Besoins En Matière De Soins De Santé Des Personnes Intersexuées



# 3.0 Besoins En Matière De Soins De Santé Des Personnes Intersexuées

## 3.1 Considérations générales en matière de soins de santé

### 3.1.1 Problèmes de santé et besoins courants des personnes intersexuées

Les personnes intersexuées peuvent être confrontées à toute une série de problèmes de santé et de besoins qui sont influencés par leurs caractéristiques biologiques uniques, les pressions sociales et les interventions médicales auxquelles elles ont pu être soumises pendant leur enfance. Ces besoins dépassent le cadre physique et s'étendent aux domaines psychologique, social et juridique. Il est essentiel de comprendre et de traiter ces questions de manière globale et centrée sur le patient afin d'améliorer la santé et le bien-être général des personnes intersexuées.

**Voici quelques problèmes de santé et besoins courants des personnes intersexuées :**

**1. Problèmes de santé physique**

Les personnes intersexuées peuvent être confrontées à des problèmes de santé physique spécifiques liés à leurs variations du développement sexuel (VDS), notamment

- **Déséquilibre hormonal:** cela concerne les problèmes de régulation hormonale ; certaines personnes intersexuées présentent des troubles entraînant une production hormonale atypique et nécessitant un traitement hormonal substitutif (THS), tandis que d'autres ont des gonades sous-développées ou retirées et peuvent avoir besoin d'un traitement hormonal substitutif à vie pour maintenir leur équilibre hormonal. La gestion des niveaux hormonaux, en particulier pendant la puberté, est importante pour favoriser le développement sain des personnes intersexuées.

- **Problèmes de fertilité :** de nombreuses variations intersexuées peuvent affecter la fertilité. Certaines personnes intersexuées peuvent ne pas avoir d'organes reproducteurs pleinement fonctionnels ou avoir subi des interventions telles que l'ablation des gonades, qui affectent leur fertilité. Il existe un manque d'informations sur la fertilité au Nigeria, une situation encore plus grave pour les personnes intersexuées, en particulier celles qui ont subi des interventions chirurgicales ou médicales à un jeune âge. Pour celles qui souhaitent concevoir, une meilleure communication et un meilleur accès aux options de préservation de la fertilité et aux services de procréation assistée sont des aspects importants des soins.



- **Risque accru de cancer:** certaines variations intersexuées, telles que le syndrome d'insensibilité complète aux androgènes (CAIS) ou les conditions où des testicules non descendus sont présents, peuvent augmenter le risque de tumeurs gonadiques. En conséquence, les protocoles médicaux devraient donner la priorité à la surveillance du cancer et aux plans de prise en charge qui respectent l'autonomie corporelle. Les personnes intersexuées devraient être pleinement informées de leurs options, y compris la surveillance par rapport à l'ablation prophylactique des gonades.

- **Complications liées aux chirurgies précoces:** la santé génitale et urogénitale est un problème auquel sont souvent confrontées de nombreuses personnes intersexuées qui ont subi des chirurgies génitales pendant la petite enfance ou l'enfance, telles que la réduction clitoridienne, la vaginoplastie ou la gonadectomie. Dans la plupart des cas, ces chirurgies entraînent des complications plus tard dans la vie, telles que des cicatrices ou des douleurs chroniques dans la région génitale, des problèmes urologiques tels que des difficultés à uriner ou des infections urinaires (IU), et une diminution de la fonction sexuelle ou du plaisir. Suivi chirurgical à long terme pour les personnes intersexuées qui ont subi des chirurgies : celles-ci peuvent avoir besoin d'un traitement continu pour ces complications.

**2. Problèmes psychologiques et de santé mentale**

- **Traumatismes liés à la médicalisation:** de nombreuses personnes intersexuées ont subi des traumatismes psychologiques résultant d'interventions médicales précoces, souvent pratiquées sans leur consentement. Ces opérations chirurgicales, qui visent à « normaliser » leur corps afin qu'il corresponde aux normes sociales de genre, entraînent au contraire une détresse émotionnelle à long terme, notamment des sentiments de trahison et de violation. Ces interventions médicales précoces affectent leur image corporelle et leur perception d'elles-mêmes, en particulier si elles ne s'identifient pas au genre qui leur a été attribué à la suite de ces opérations. De nombreuses personnes intersexuées souffrent de dysphorie de genre liée aux procédures médicales ou aux traitements hormonaux.

- **Dépression et anxiété:** en raison de la stigmatisation qui entoure les corps intersexués à l'échelle mondiale et au Nigeria, de nombreuses personnes intersexuées souffrent d'anxiété, de dépression et d'un sentiment d'isolement. L'absence d'environnements favorables et valorisants (au sein des familles, des services de santé et de la société) aggrave encore ces problèmes de santé mentale. Un soutien psychosocial est nécessaire. Les personnes intersexuées devraient avoir accès à des thérapies et à des consultations en santé mentale qui tiennent compte des traumatismes subis et valorisent leur genre. Un accompagnement qui aborde spécifiquement l'impact psychologique de la médicalisation, les problèmes d'image corporelle et la stigmatisation sociale est essentiel pour la santé mentale à long terme.

- **Identité et exploration de soi:** De nombreuses personnes intersexuées sont en conflit avec leur identité de genre et souffrent de dysphorie de genre, en particulier si le genre qui leur a été attribué à la naissance ne correspond pas à leur propre perception d'elles-mêmes. Dans la plupart des cas, cela entraîne un conflit interne et une confusion identitaire. L'accès à des services de conseil affirmant le genre est important; il aide les personnes à explorer leur identité de manière sûre et encourageante, sans pression pour se conformer aux attentes binaires en matière de genre. Les personnes intersexuées devraient également avoir accès à des soins médicaux affirmant leur genre si elles souhaitent changer de genre ou modifier leur expression de genre.

**3. Besoins sociaux et juridiques en matière de santé**

- **Stigmatisation et isolement social:** dans de nombreuses cultures, notamment au Nigeria et dans d'autres régions d'Afrique, les personnes intersexuées sont victimes d'une forte stigmatisation en raison des conceptions traditionnelles du genre et du sexe. Les caractéristiques intersexuées sont souvent mal comprises, ce qui conduit à l'ostracisme, à la discrimination et au rejet par les familles et les communautés. Lorsque nous commençons à mettre en place des espaces sûrs, des groupes de soutien par les pairs et des réseaux de défense des droits où les personnes intersexuées peuvent entrer en contact avec d'autres personnes qui partagent des expériences similaires, elles commencent à développer leur résilience et à réduire leur isolement social.

**3.1.2 Besoins en matière de soins de santé spécifiques à l'âge**

Les personnes intersexuées ont des besoins particuliers en matière de soins de santé, qui varient considérablement selon les différentes étapes de leur vie. Ces besoins ne sont pas seulement liés à leur développement physique, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, mais concernent également des aspects psychologiques, sociaux et émotionnels qui nécessitent une attention particulière à différents âges.

Il est essentiel de comprendre ces besoins dans un contexte spécifique à chaque âge afin de fournir des soins complets et centrés sur le patient qui respectent l'autonomie, le bien-être et l'identité des personnes intersexuées, en particulier ici au Nigeria.

**Vous trouverez ci-dessous un aperçu général des besoins en matière de soins de santé spécifiques à chaque âge pour les personnes intersexuées:**

1. **Besoins en matière de soins pédiatriques (de la petite enfance à la première enfance)**

**Considérations clés:**

- **Diagnostic et suivi:** de nombreuses variations intersexuées sont identifiées à la naissance ou pendant la petite enfance, souvent grâce à des examens physiques, des tests génétiques ou des évaluations hormonales. Au cours de la phase pédiatrique, il est important que les professionnels de santé diagnostiquent avec précision la variation intersexuée tout en évitant les procédures invasives inutiles qui pourraient causer des dommages ou de la détresse au bébé intersexué.

- **Interventions médicales non urgentes:** L'un des problèmes les plus importants dans les soins de santé intersexués pour les nourrissons et les jeunes enfants est la tendance historique à pratiquer des interventions chirurgicales irréversibles visant à « normaliser » l'apparence génitale, également appelées mutilations génitales intersexuées (MGI), tout comme les MGF. Les droits humains et l'éthique médicale soulignent l'importance d'éviter les interventions non urgentes sur les enfants intersexués jusqu'à ce que l'enfant puisse donner son consentement éclairé.

- **Accompagnement et soutien parental:** Les soins pédiatriques se concentrent souvent sur l'accompagnement et l'éducation des parents concernant la variation intersexuée de leur enfant. Les prestataires de soins de santé doivent fournir des informations transparentes et non stigmatisantes afin d'aider les parents à comprendre l'importance de refuser les interventions chirurgicales non urgentes. Les familles d'enfants intersexués doivent être mises en relation avec des services de conseil et des organisations dirigées par des personnes intersexuées et spécialisées dans ce domaine, telles que Intersex Nigeria, afin de réduire leur anxiété et d'apporter un soutien à l'enfant.

2. **Besoins en matière de soins de santé à l'adolescence**

**Considérations clés:**

- **Puberté et gestion hormonale:** pendant l'adolescence, certaines personnes intersexuées vivent la puberté différemment selon leur variation. Des traitements hormonaux peuvent être proposés pour favoriser le développement des caractères sexuels secondaires, mais ceux-ci doivent être présentés comme des options plutôt que comme des impératifs. Il est important que les adolescents aient le temps et les informations nécessaires pour explorer leur identité de genre sans être contraints à des interventions hormonales.

- **Consentement éclairé et prise de décision:** L'adolescence est une période où la plupart des personnes intersexuées prennent davantage conscience de leur corps et de leur identité de genre. Les décisions médicales doivent être prises avec la pleine participation de l'adolescent, en veillant à ce qu'il ait l'autonomie nécessaire pour faire des choix éclairés concernant ses soins de santé. Les discussions sur les éventuelles interventions chirurgicales, les traitements hormonaux ou autres interventions doivent être abordées avec prudence, en mettant l'accent sur le droit de l'adolescent à l'autodétermination.

- **Soutien psychosocial:** Les adolescents sont souvent confrontés à des défis sociaux et émotionnels accrus, notamment en ce qui concerne l'image corporelle, l'identité et les relations avec leurs pairs. Les adolescents intersexués peuvent souffrir de dysphorie de genre, de sentiments d'isolement, de confusion ou de stigmatisation en raison de leurs caractéristiques physiques uniques ou liées à des procédures médicales ou à des traitements hormonaux. Un soutien complet en matière de santé mentale, comprenant l'accès à des services de conseil, au soutien de pairs et à des groupes de défense des personnes intersexuées, est utile pour promouvoir une santé mentale et une estime de soi positives.

- **Éducation à la santé sexuelle:** Les adolescents doivent recevoir une éducation à la santé sexuelle précise et adaptée à leur âge, qui réponde à leurs besoins spécifiques. Cela inclut des discussions sur la fertilité, l'orientation sexuelle, la fonction sexuelle et les relations saines, sans jugement et de manière inclusive.

3. **Besoins en matière de soins de santé à l'âge adulte**

**Considérations clés:**

- **Maintien de la santé physique:** Les adultes présentant des variations intersexuées peuvent avoir besoin de soins médicaux continus liés à leur santé physique, notamment la gestion hormonale, la santé reproductive et la gestion des résultats chirurgicaux d'interventions antérieures. Il est important que les prestataires de soins de santé connaissent bien les variations intersexuées afin d'offrir des soins appropriés, notamment le dépistage des problèmes de santé qui peuvent être plus fréquents chez certaines populations intersexuées.

- **Santé sexuelle et reproductive:** Les adultes intersexués peuvent avoir des questions sur la fertilité, la fonction sexuelle, l'orientation sexuelle et la possibilité d'avoir des enfants. L'accès aux services de fertilité, au conseil et aux options de reproduction doit être fourni de manière respectueuse et non discriminatoire. En outre, les adultes peuvent avoir besoin d'aide pour faire face aux conséquences physiques ou psychologiques des interventions chirurgicales précoces, telles que les problèmes de sensibilité génitale ou de cicatrices.

- **Santé mentale et soutien social:** De nombreux adultes intersexués sont confrontés à des difficultés psychologiques persistantes et peuvent souffrir de dysphorie de genre, en particulier s'ils ont subi des interventions chirurgicales non consenties ou s'ils se sentent éloignés des normes sociales relatives au genre et au sexe. Le soutien en matière de santé mentale reste essentiel, avec des possibilités de rencontre entre pairs, de thérapie et de participation à des réseaux de défense des personnes intersexuées. Pour ceux qui ont subi un traumatisme lié à des interventions médicales, des soins tenant compte du traumatisme sont indispensables.

- **Identité et expression de genre:** Certaines personnes intersexuées peuvent s'identifier à un genre différent de celui qui leur a été attribué à la naissance, ou préférer rejeter complètement les catégories de genre traditionnelles. Les adultes devraient avoir accès à des soins de santé affirmant leur genre, qui comprennent non seulement des options chirurgicales et hormonales, mais aussi un soutien pour les expressions de genre non binaires ou fluides.



# 4.0

# Interventions Médicales Et Considérations Éthiques



# 4.0 Interventions Médicales Et Considérations Éthiques

## 4.1 Historique des interventions médicales sur les personnes intersexuées

Avant les années 1960, lorsqu'un enfant intersexué naissait, son entourage, à savoir ses parents et ses médecins, faisait une supposition et lui attribuait un sexe. Les parents les élevaient ensuite selon les normes sociales de genre. Parfois, ces enfants intersexués subissaient des harcèlements et des discriminations en raison de leurs caractéristiques atypiques, mais beaucoup menaient une vie bien équilibrée à l'âge adulte. Cependant, au cours des années 1960, sur la base de recommandations non prouvées d'un seul psychologue éminent, John Money, les normes médicales dans les pays développés ont commencé à changer radicalement. Les médecins ont commencé à recommander des solutions chirurgicales au « problème » supposé des caractéristiques intersexuées.[7]

Cette histoire de la chirurgie est aussi une histoire de honte et de stigmatisation. Dans certains cas, les médecins ont demandé aux parents de cacher le diagnostic et le traitement à l'enfant, inculquant ainsi un sentiment de honte aux parents et aux enfants. De nombreuses personnes intersexuées n'ont appris l'existence de leur condition que lorsqu'elles ont eu accès à leur dossier médical à l'âge adulte, parfois même après 50 ans, et la plupart d'entre elles ne l'ont jamais su de toute leur vie. Au cours du XXe siècle, les interventions médicales sur les personnes intersexuées ont été réalisées sans leur consentement, la plupart des procédures étant effectuées pendant la petite enfance ou l'enfance. L'objectif était de « corriger » l'ambiguïté perçue du sexe et d'éviter une future stigmatisation sociale. Ces chirurgies, souvent qualifiées de "correctives" ou de "normalisantes", étaient irréversibles et généralement pratiquées dans l'idée que l'enfant se conformerait plus tard au genre qui lui avait été attribué.

Cependant, de nombreuses personnes intersexuées ont grandi en subissant des traumatismes physiques et émotionnels à la suite de ces interventions chirurgicales. Beaucoup ont signalé des complications importantes, notamment une perte de sensibilité sexuelle, des douleurs chroniques et une détresse psychologique résultant d'une dysphorie de genre ou d'un sentiment de violation. Certaines personnes se sont ensuite identifiées à un genre différent de celui qui leur avait été attribué à la naissance, rendant ces interventions chirurgicales non seulement inutiles, mais aussi néfastes. Ces expériences ont conduit à un mouvement croissant de lutte contre les interventions médicales non consenties, qualifiant ces pratiques de violations de l'autonomie corporelle et des droits humains.[8]

À la fin du XXe siècle, les personnes intersexuées et leurs alliés ont commencé à s'organiser contre la médicalisation des corps intersexués. Des groupes tels que l'Intersex Society of North America (ISNA), fondée en 1993, ont joué un rôle essentiel dans la sensibilisation aux dommages à long terme causés par les interventions médicales précoces. Les militants intersexués ont insisté sur la nécessité de l'autodétermination, plaidant pour un moratoire sur les chirurgies non consenties et soulignant l'importance de l'intégrité physique.

[7] *https://www.hrw.org/report/2017/07/25/i-want-be-nature-made-me/medically-unnecessary-surgeries-intersex-children-us*
[8] *https://chatgpt.com/c/66e6d8f4-2d70-8009-a85a-38a3d9e45e35*

Un moment historique a eu lieu en 1996, lorsque la militante intersexuée Cheryl Chase, fondatrice de l'ISNA, a publiquement condamné les chirurgies génitales infantiles lors de la réunion annuelle de l'Académie américaine de pédiatrie. Cet événement a mis les questions liées à l'intersexualité au premier plan de la conscience publique et a ouvert la voie à un débat plus large sur les droits humains des personnes intersexuées.

Les organisations internationales de défense des droits humains reconnaissent de plus en plus l'impact néfaste des interventions médicales non consenties sur les personnes intersexuées. En 2013, les Nations unies ont condamné ces pratiques, les qualifiant de violations des droits humains assimilables à de la torture. Le Comité des Nations unies contre la torture et le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture ont tous deux appelé à mettre fin aux opérations chirurgicales non consenties, exhortant les pays à adopter des cadres juridiques qui protègent l'autonomie corporelle des personnes intersexuées.

Cependant, malgré ces changements, la pratique de la mutilation génitale des personnes intersexuées et des interventions chirurgicales précoces reste courante dans de nombreuses régions du monde, en particulier au Nigeria. Les protocoles médicaux continuent de varier considérablement et, dans certains cas, des pratiques obsolètes persistent. Les défenseurs des personnes intersexuées et les organisations de défense des droits humains continuent de faire pression pour une plus grande responsabilité, une plus grande transparence et un meilleur respect des directives éthiques dans les soins de santé destinés aux personnes intersexuées.

## 4.2 Implications éthiques des interventions chirurgicales et des traitements hormonaux

### Consentement éclairé

- Les parents d'enfants intersexués consentent aux interventions chirurgicales sur la base des conseils des professionnels de santé.
- Les professionnels de santé n'informent pas toujours les parents que leur enfant pourrait ne pas s'identifier au genre attribué lors de l'intervention chirurgicale.
- Sur la base du discours des professionnels de santé, la chirurgie est présentée aux parents comme la solution par défaut plutôt que comme une option.
- Sans consentement éclairé, l'intervention chirurgicale peut être considérée comme une agression sur l'enfant ou le nourrisson.
- Le fait de minimiser les autres issues possibles de l'opération soulève des questions quant à savoir si les parents donnent véritablement leur consentement éclairé, car ils ne comprennent pas les risques potentiels liés à cette procédure.

**Principe de non-malfaisance**

Il s'agit d'un principe éthique fondamental, particulièrement important dans le domaine des soins de santé et de la bioéthique. Il signifie essentiellement « ne pas nuire » ou, plus complètement, le devoir d'éviter de causer du tort.

- Les études menées par le Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe en 2017 sur la chirurgie intersexuée n'ont pas encore trouvé de données fiables confirmant sa sécurité et ses avantages pour les enfants concernés. [9]

- Des patients intersexués adultes ont rapporté des cas de « dysfonctionnement génital, cicatrices, perte de sensibilité sexuelle, perte de fertilité, douleurs chroniques et attribution erronée du sexe, avec excision irréversible des tissus génitaux et gonadiques » à la suite d'une chirurgie génitale pratiquée pendant leur petite enfance. En raison de la négligence de leurs médecins, ces patients ont subi des interventions chirurgicales inutiles et irréversibles.

- Il est pratiquement impossible d'agir dans "l'intérêt supérieur du patient", car il n'existe aucune échelle objective permettant de déterminer avec précision l'intérêt supérieur de chaque patient à mesure qu'il grandit. Le médecin ne peut garantir qu'une décision aussi irréversible qu'une chirurgie de réassignation sexuelle aura un résultat favorable pour un nourrisson ou un enfant après la puberté.

- Si un nourrisson ou un enfant intersexué rejette le sexe qui lui a été attribué chirurgicalement, il risque de souffrir toute sa vie de douleurs physiques et psychologiques.

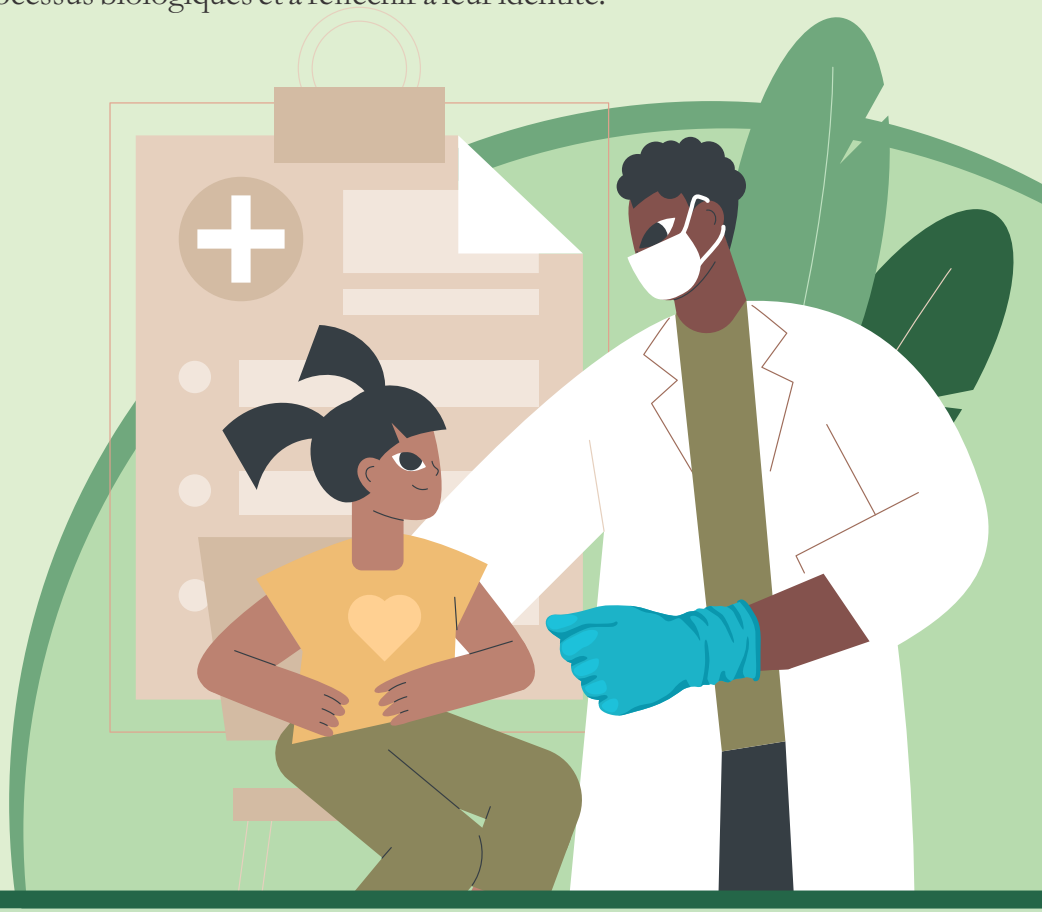
**Principe d'autonomie**

- Les États-Unis sont le seul membre de l'ONU à ne pas avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE).

- La CDE soutient l'idée que les États doivent « veiller à ce que personne ne soit soumis à des traitements médicaux ou chirurgicaux inutiles pendant la petite enfance ou l'enfance, "garantir l'intégrité physique, l'autonomie et l'autodétermination des enfants concernés, et fournir aux familles ayant des enfants intersexués des conseils et un soutien adéquats".

- Les chirurgies intersexuées dangereuses et irréversibles violent le droit d'une personne à l'autonomie sur son propre avenir.

- L'enfant doit être respecté en tant que membre du processus décisionnel, car même les jeunes enfants, dès l'âge de 6 ou 7 ans, peuvent commencer à exprimer leurs préférences, à comprendre les processus biologiques et à réfléchir à leur identité.



[9] *https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1382&context=ures#:~:text=The%20performance%20of%20medically%20unnecessary,the%20sex%20assigned%20to%20them*

## 4.3 Approches alternatives et importance des soins centrés sur le patient

Les approches alternatives en matière d'intervention médicale sur les personnes intersexuées visent à retarder les interventions chirurgicales non consenties, à fournir des soins éclairés et holistiques, et à mettre l'accent sur l'autonomie et la prise de décision du patient. Les soins centrés sur le patient sont importants dans ces approches, car ils privilégient les droits, les désirs et le bien-être à long terme de l'individu plutôt que les normes sociales ou les résultats esthétiques.

**Voici quelques approches alternatives clés:**

1

### Report des interventions chirurgicales non urgentes

L'un des changements les plus significatifs dans les soins aux personnes intersexuées est l'importance accordée au report des interventions médicales non urgentes, telles que les chirurgies génitales ou les traitements hormonaux, jusqu'à ce que la personne soit en âge de donner son consentement éclairé. Seules les interventions médicalement nécessaires pour la santé immédiate de l'enfant (telles que le traitement de pathologies mettant sa vie en danger) peuvent être réalisées de manière éthique pendant la petite enfance. Les chirurgies esthétiques, en particulier celles liées à l'assignation du genre, sont désormais reportées afin de permettre à la personne de décider de son propre cheminement en toute autonomie.

2

### Soutien psychosocial et familial

Le fait de fournir un accompagnement psychologique et une éducation aux familles les aide considérablement à comprendre la variation intersexuée de leur enfant ou de leur proche, ce qui atténue toute pression sociale les poussant à intervenir tôt. Ce soutien aide les familles à créer un environnement positif et accueillant pour leur enfant.

Mettre l'accent sur l'estime de soi et l'inclusion sociale : les enfants intersexués sont souvent victimes de stigmatisation ou d'exclusion sociale. Le soutien psychologique et social aide à développer la résilience et l'acceptation de soi, ce qui est souvent plus bénéfique que des interventions médicales précoces.

3

### Équipes de soins multidisciplinaires

Il est important de mettre en place des soins holistiques et collaboratifs. Une équipe multidisciplinaire, qui devrait comprendre des endocrinologues, des urologues, des psychologues, des éthiciens et des organisations de défense des droits des personnes intersexuées, devrait collaborer pour fournir des soins complets. L'accent est mis sur les besoins physiques, émotionnels et psychologiques de l'individu plutôt que sur la simple « normalisation » de son corps.

4

## Consentement éclairé et autonomie du patient

Au cœur de l'approche alternative se trouve la garantie que l'individu dispose de l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions concernant son corps. Cela signifie qu'il faut reporter toute décision concernant les interventions chirurgicales ou les traitements hormonaux jusqu'à ce que le patient puisse pleinement comprendre les risques, les avantages et les implications des procédures. Lorsque les individus sont en âge de prendre des décisions éclairées, ils doivent recevoir des informations claires et impartiales sur les options qui s'offrent à eux, y compris les résultats potentiels à long terme et les alternatives à la chirurgie.

5

## Approches affirmant le genre et non binaires

**Affirmer l'identité de genre:** plutôt que de supposer un résultat binaire pour le sexe et le genre, les approches alternatives des soins aux personnes intersexuées affirment un large spectre d'identités de genre. Cette approche évite la coercition vers un rôle ou une identité de genre spécifique, permettant à l'individu d'explorer son propre genre sans pression médicale.
**Options non chirurgicales d'affirmation du genre:** pour ceux qui souhaitent aligner leurs caractéristiques physiques sur leur identité de genre plus tard dans leur vie, les soins centrés sur le patient peuvent inclure une hormonothérapie ou des chirurgies d'affirmation du genre, en fonction du choix éclairé de l'individu.

### Importance des soins centrés sur le patient

Un modèle de soins centrés sur le patient encourage la collaboration active et la prise de décision partagée entre les patients, les familles, les soignants et les prestataires. Les soins centrés sur le patient sont essentiels dans les interventions médicales intersexuées, car ils garantissent que les besoins, les préférences et les droits du patient sont au centre des préoccupations.

**Voici quelques éléments à prendre en compte pour prodiguer des soins centrés sur le patient:**[10]

1. Les soins sont collaboratifs et coordonnés et vont au-delà du bien-être physique pour inclure également les aspects émotionnels, sociaux et financiers de la situation du patient.
2. Les patients doivent toujours avoir le contrôle total lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant leurs propres soins et traitements.
3. Les cliniciens sont là pour informer, conseiller et soutenir, mais c'est au patient qu'il appartient en dernier ressort de déterminer la ligne de conduite à suivre.
4. Les patients doivent comprendre parfaitement les procédures et les traitements auxquels ils vont être soumis, tandis que les cliniciens doivent s'efforcer de les informer et de les mettre à l'aise autant que possible, en particulier lorsqu'ils les traitent pour une maladie ou une blessure complexe ou douloureuse.

### Approche des soins centrés sur le patient:

1. Protège l'autonomie en respectant l'autonomie de l'individu et en lui permettant de prendre des décisions éclairées concernant son corps et ses soins de santé au moment opportun dans sa vie.
2. Réduit les préjudices: en évitant les interventions chirurgicales prématurées et non consenties, les soins centrés sur le patient réduisent le risque de préjudices physiques et émotionnels causés par des procédures qui pourraient ne pas correspondre à l'identité de genre ou aux désirs de l'individu plus tard dans sa vie.
3. Améliore la santé mentale des personnes intersexuées afin qu'elles se sentent maîtres de leur corps et prennent des décisions plus susceptibles d'avoir des résultats psychologiques positifs, notamment une meilleure estime de soi, une réduction de l'anxiété et une diminution du risque de traumatisme associé aux chirurgies précoces.
4. Promouvoir des soins éthiques et respectueux qui s'orientent vers des soins centrés sur le patient, conformes aux normes bioéthiques modernes, mettant l'accent sur la dignité, le respect et les droits humains. Cela permet d'éviter les préjudices historiques associés à la médicalisation des corps intersexués afin de les conformer aux normes sociales.

[10] *https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/why-patientcentered-care-is-so-important*



# 5.0

## Créer Un Environnement De Soins De Santé Solidaire Et Inclusif Pour Les Personnes Intersexuées

# 5.0 Créer Un Environnement De Soins De Santé Solidaire Et Inclusif Pour Les Personnes Intersexuées

## 5.1 Stratégies de communication

La communication est fondamentale à tous les niveaux du système de santé, mais elle peut s'avérer problématique. Heureusement, les professionnels de la santé peuvent prendre des mesures pour surmonter de nombreux obstacles courants à une communication efficace. Une communication efficace dans le domaine des soins de santé aux personnes intersexuées est essentielle pour créer des environnements favorables et inclusifs. Elle contribue à instaurer la confiance entre les patients et les prestataires de soins de santé, à favoriser la compréhension et à garantir que les personnes intersexuées et leurs familles se sentent respectées et écoutées. Les prestataires de soins de santé doivent adopter des pratiques de communication respectueuses et employer des stratégies sensibles pour aborder des sujets difficiles, et former leur personnel à l'utilisation d'un langage inclusif envers les personnes intersexuées.

### 5.1.1 Principes d'une communication respectueuse et efficace

**Respecter l'autonomie et l'individualité:**

- **Approche centrée sur le patient:** respecter l'autonomie de l'individu signifie placer ses besoins, ses désirs et son bien-être au centre des soins. Les prestataires de soins de santé doivent communiquer de manière à permettre aux personnes intersexuées de prendre des décisions éclairées concernant leurs soins de santé. Cela implique notamment d'éviter les suppositions fondées sur les normes sociales ou les notions binaires de sexe et de genre.

- **Confidentialité et vie privée:** il est essentiel de respecter la vie privée des personnes intersexuées. Les discussions concernant leur état de santé, leur identité de genre ou leur autonomie corporelle doivent rester confidentielles, sauf si le patient y consent explicitement. Cela permet de garantir la confiance et de protéger contre toute stigmatisation ou exposition inutile.

- **Écoute et empathie:** les prestataires de soins de santé doivent privilégier l'écoute active et faire preuve d'empathie lorsqu'ils communiquent avec des personnes intersexuées. L'empathie implique de comprendre les défis émotionnels et les expériences auxquels les personnes intersexuées peuvent être confrontées, sans jugement ni idées préconçues. Cette approche favorise un environnement favorable où les personnes se sentent valorisées et comprises.

**Clarté et transparence**:

- **Utilisation d'un langage clair et sans jargon**: les prestataires de soins de santé doivent expliquer les informations médicales dans un langage simple et non technique, accessible à la personne et à sa famille. Cela favorise une meilleure compréhension et permet une prise de décision éclairée.

- **Honnêteté face aux incertitudes:** s'il existe des incertitudes concernant le diagnostic ou les options de traitement, les prestataires de soins de santé doivent les communiquer de manière transparente. Il est essentiel de reconnaître les inconnues, en particulier en ce qui concerne les résultats à long terme ou les approches thérapeutiques non standardisées.

**Communication non directive:**

- **Éviter les formulations qui exercent une pression**: lors des discussions sur les options de soins de santé, en

particulier les interventions chirurgicales ou hormonales, il est essentiel d'utiliser un langage non directif. Les prestataires doivent présenter toutes les options de manière égale, sans imposer une ligne de conduite comme étant supérieure ou nécessaire. Cela donne aux personnes intersexuées la possibilité de prendre des décisions en fonction de leurs valeurs et de leurs préférences.

- **Soutenir l'expression de soi:** encourager les personnes intersexuées à exprimer librement leurs sentiments et leurs préoccupations, en particulier sur les questions d'identité de genre, d'image corporelle et de décisions en matière de soins de santé. Cette communication ouverte favorise la conscience de soi et l'autonomisation.

## 5.1.2 Stratégies pour aborder des sujets sensibles avec les personnes intersexuées et leurs familles

### Commencez par établir une relation de confiance et d'empathie

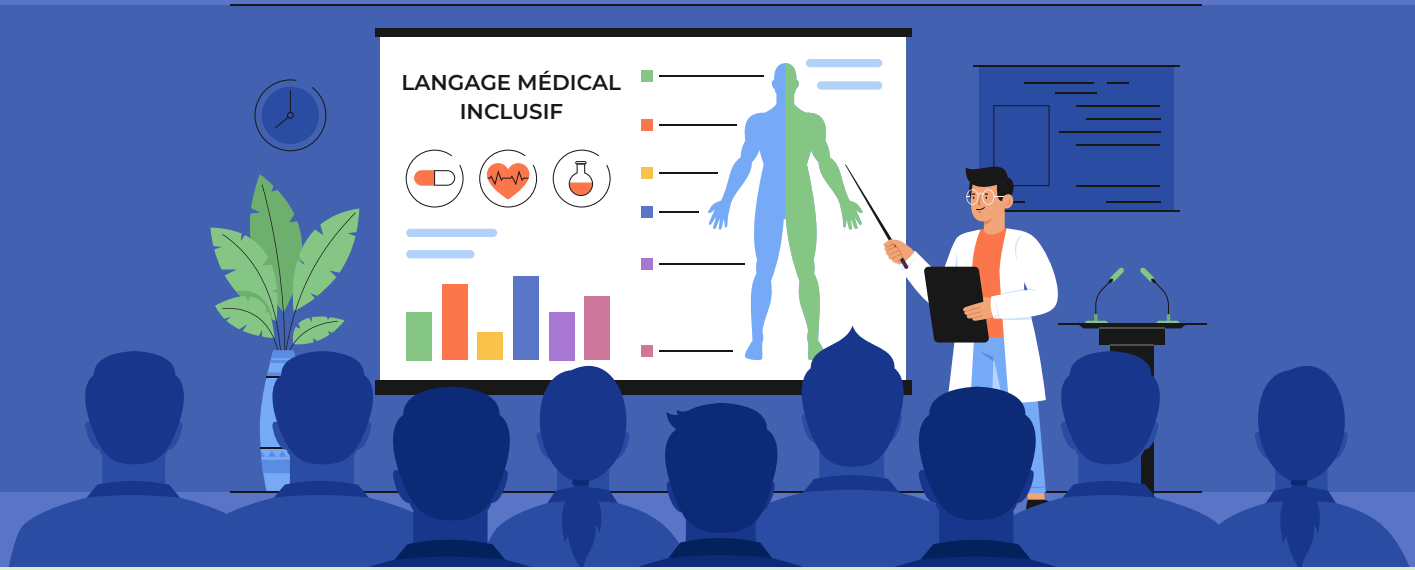
Les conversations sensibles sur les variations intersexuées, les interventions médicales et l'identité de genre nécessitent un environnement favorable et sans jugement. Les professionnels de santé doivent créer une atmosphère sécurisante en faisant preuve de compréhension, en évitant les conversations précipitées et en laissant suffisamment de temps pour les questions et les réflexions. Il est également important de faire comprendre que les variations intersexuées sont des différences biologiques naturelles, et non des urgences médicales, et qu'elles sont plus courantes que les gens ne le pensent. En normalisant les conditions intersexuées, les professionnels de santé peuvent atténuer la peur et l'anxiété qui accompagnent souvent les discussions sur le fait d'être « différent » des normes sociales.

### Adapter la communication à l'âge et au stade de développement

Pour les enfants et les adolescents, il est essentiel d'utiliser un langage adapté à leur âge lorsque l'on aborde des sujets sensibles avec un jeune intersexué. Les professionnels de santé doivent éviter de submerger les jeunes avec des informations médicales complexes, tout en s'assurant qu'ils comprennent les aspects essentiels de leur condition. Encouragez la curiosité et l'exploration de l'identité de genre de manière positive. Les parents ressentent souvent de l'anxiété ou de la culpabilité lorsqu'ils apprennent la variation intersexuée de leur enfant. Abordez ces émotions avec compassion et évitez de présenter la conversation comme si quelque chose "n'allait pas" chez l'enfant. Insistez plutôt sur le fait que le rôle de l'équipe de soins de santé est de favoriser le bien-être de l'enfant, et que c'est exactement ce que vous allez faire.

### Discuter des interventions médicales

Lorsque vous discutez des interventions médicales, en particulier des chirurgies non urgentes ou des traitements hormonaux, veillez à ce que la conversation soit non directive et impartiale. Présentez les risques et les avantages de chaque option, en insistant notamment sur la possibilité de reporter toute intervention jusqu'à ce que la personne soit capable de prendre ses propres décisions. Cette approche aide la famille à se sentir en contrôle tout en favorisant le bien-être à long terme de la personne intersexuée. Encouragez les familles à prendre leur temps pour prendre des décisions concernant des procédures irréversibles. Expliquez que le report de certaines interventions médicales, telles que les chirurgies d'affirmation du genre, permet à la personne de participer activement au processus décisionnel plus tard dans sa vie.




### 5.1.3 Former le personnel à l'utilisation d'un langage et d'une communication adaptés aux personnes intersexuées

Le langage est inclusif lorsque nous utilisons des mots qui témoignent de notre respect pour la manière dont les personnes décrivent leur propre corps, leur genre et leurs relations. Il est important que chacun fasse preuve de ce respect, même lorsque nous décrivons ces personnes en leur absence, et il est particulièrement essentiel que les prestataires de soins de santé veillent à adopter une pratique médicale solidaire, conviviale et inclusive.
Des chercheurs ont découvert que la façon dont les autres nous décrivent a un impact considérable sur notre santé et notre bien-être, ainsi que sur notre propension à consulter un professionnel de santé lorsque cela est nécessaire.[11]

- **Éviter les termes stigmatisants:** le personnel de santé doit éviter les termes qui pathologisent ou stigmatisent les variations intersexuées. Des mots tels que « trouble », « anormal » ou « ambigu » peuvent être blessants et renforcer les stéréotypes négatifs. Utilisez plutôt des termes respectueux tels que « variation intersexuée » ou « différences dans le développement sexuel (DSD) », et respectez toujours les préférences du patient en matière de langage, car certains peuvent ne préférer aucun des termes ci-dessus.

- **Formation à la sensibilité culturelle:** le personnel doit recevoir une formation sur la compétence culturelle, en particulier dans le contexte nigérian, où les attitudes culturelles et religieuses à l'égard du sexe, du genre et de l'identité sont très diverses. Cette formation aidera les prestataires de services de santé à aborder des sujets sensibles en tenant compte des dynamiques culturelles, tout en respectant les principes éthiques et les droits humains.

- **Éducation sur les droits des personnes intersexuées:** il est très important d'éduquer le personnel de santé sur les droits des personnes intersexuées, notamment le droit au consentement éclairé, à l'autonomie corporelle et à l'accès à des soins de santé non discriminatoires. Le personnel doit comprendre que les chirurgies précoces et non consenties ont évolué et ne sont plus considérées comme la meilleure pratique, et que l'accent doit être mis sur le bien-être mental et physique à long terme de la personne.

[11] *https://www.parliament.nsw.gov.au/lcdocs/other/12075/Inclusive%20language%20guide %20-%20Respecting%20people%20of%20intersex,%20trans%20and%20gender%20diverse%20experience.pdf*

● **Formation aux pratiques tenant compte des traumatismes:** de nombreuses personnes intersexuées, en particulier celles qui ont subi des interventions médicales non consenties, souffrent souvent de traumatismes liés à leurs expériences en matière de soins de santé. Il convient de former le personnel à reconnaître les signes de traumatisme et à y répondre avec sensibilité, en veillant à ce que les soins soient dispensés de manière à éviter toute nouvelle traumatisation et à favoriser la guérison et le bien-être général.

● **Encourager le soutien émotionnel:** le personnel doit être formé pour offrir un soutien émotionnel et orienter les personnes vers des services de conseil ou des groupes de soutien si nécessaire. Comprendre l'impact psychologique de l'intersexualité, en particulier dans les environnements où la stigmatisation est répandue, peut aider le personnel à fournir des soins compatissants et efficaces.

## Liste de contrôle pour la communication avec les patients intersexués

**Un aspect essentiel des soins affirmatifs consiste à utiliser un langage inclusif dans la communication avec tous les patients :**

- Consigner les informations du patient dans les dossiers médicaux électroniques
- Utiliser le nom et les pronoms choisis par la personne de manière cohérente dans l'ensemble du centre de santé
- Vérifier fréquemment, car ces informations peuvent changer
- Reprendre les termes utilisés par les patients pour se décrire, décrire les parties de leur corps et leur diagnostic
- Utiliser un langage inclusif et éviter les termes genrés. Par exemple, au lieu de demander "Avez-vous un petit ami?", demandez "Êtes-vous en couple?" Au lieu de demander "Veuillez retirer votre soutien-gorge et votre pantalon", dites "Veuillez retirer vos sous-vêtements".
- Ne posez que des questions pertinentes pour les besoins actuels du patient en matière de santé. Demandez-vous : "Que sais-je ? Que dois-je savoir de plus pour traiter ce patient ? Comment puis-je demander les informations don't j'ai besoin de manière délicate?"
- Assurez-vous que la communication est bidirectionnelle, authentique et active.
- Examinez vos propres préjugés implicites et explicites sur l'identité de genre, l'expression de genre et l'anatomie.
- Participez à des sessions de formation sur les soins de santé affirmant l'intersexualité afin de vous assurer que vous utilisez les stratégies de communication actuelles et que vous suivez les protocoles à jour en matière de soins aux personnes intersexuées.

### 5.1.4 Meilleures pratiques pour obtenir et documenter le consentement éclairé.

Afin de s'assurer que le patient a reçu suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée quant au déroulement de son traitement médical, les éléments suivants doivent généralement être discutés et consignés dans le dossier médical [12]:

- Détails sur la nature de la maladie et le diagnostic du patient
- Indications relatives au plan de traitement, à la procédure ou au médicament proposés, ainsi que pronostic prévu
- Description du traitement ou de la procédure proposés, y compris les médicaments qui seront prescrits et leur objectif
- Résultat probable, en particulier s'il est difficile à prévoir, et évolution prévue du patient après la procédure/le traitement
- Les modifications ou prolongations potentielles du traitement ou de l'intervention
- Les avantages possibles de l'intervention
- Les risques et effets secondaires les plus probables et les plus graves de l'intervention, du traitement ou du médicament, précédés d'une déclaration générale inclusive, telle que "y compris, mais sans s'y limiter..."
- Une déclaration concernant les complications imprévues/les interventions médicales supplémentaires
- Méthodes alternatives raisonnables de traitement ou absence de traitement, y compris les risques, les avantages et le pronostic associés à chaque alternative ou à l'absence de traitement.
- Notification des procédures expérimentales ou d'investigation.

[12] *https://www.svmic.com/resources/newsletters/218/informed-consent-best-practices*

**Lignes directrices relatives au consentement éclairé pour les interventions médicales**

Le consentement éclairé dans le cadre d'interventions médicales visant à "normaliser" le corps des personnes intersexuées est un élément essentiel qui repose sur le droit des patients intersexués à prendre des décisions autonomes concernant leur propre santé, comme mentionné ci-dessus.

**Les professionnels de santé doivent:**

1. Reconnaître aux personnes intersexuées le droit de prendre des décisions éclairées concernant leur propre corps. Les interventions médicales doivent respecter l'autonomie et l'intégrité corporelles du patient.

2. S'abstenir de pratiquer des interventions médicales non urgentes sur des nourrissons et des adolescents intersexués, en particulier celles qui sont irréversibles ; celles-ci doivent être reportées jusqu'à ce que la personne soit en âge de donner son consentement éclairé.

3. Fournir à leurs patients les informations qu'ils demandent ou dont ils ont besoin concernant leur variation intersexuée, son traitement et son pronostic.

4. Veiller à ce que si des interventions médicales sont jugées nécessaires pour la santé du nourrisson ou de l'enfant, elles soient limitées aux besoins médicaux vitaux ou urgents.

5. Informer leurs patients de la manière la plus compréhensible possible. Les informations doivent être fournies dans un langage que le patient comprend et d'une manière qui tienne compte de son niveau d'alphabétisation, de sa compréhension, de ses valeurs et de ses croyances.

6. Veiller à ce que, lorsque des mineurs sont concernés, les décisions soient prises en consultation avec eux d'une manière adaptée à leur âge, en faisant appel à une équipe multidisciplinaire comprenant des psychologues et des spécialistes en éthique médicale.

7. Donner la priorité à la fourniture d'informations complètes, transparentes et facilement compréhensibles sur les options médicales disponibles, notamment:

    - La nature et l'objectif de l'intervention proposée.
    - Les alternatives à l'intervention proposée, y compris la possibilité de ne subir aucune intervention.
    - Les risques potentiels, les avantages et les résultats à long terme de chaque option.

8. Les informations doivent inclure la possibilité d'implications physiques, d'effets psychologiques et l'impact sur la fertilité et la fonction sexuelle.

9. S'abstenir de dissimuler toute information, investigation, traitement ou procédure dont le professionnel de santé sait qu'ils seraient dans l'intérêt du patient..

10. Appliquer le principe du consentement éclairé comme un processus continu.

11. Permettre aux patients d'accéder à leur dossier medical [13].

12. Les professionnels de santé doivent connaître et respecter les normes internationales en matière de droits humains, qui préconisent la protection des personnes intersexuées contre les interventions médicales inutiles et irréversibles.

13. Le processus d'obtention du consentement éclairé doit être bien documenté, avec des comptes rendus clairs de toutes les discussions et décisions prises par le patient ou ses parents/tuteurs.

Le consentement doit être réexaminé périodiquement, en particulier dans les cas d'interventions médicales à long terme ou par étapes. Les patients doivent pouvoir retirer leur consentement à tout moment s'ils reconsidèrent leur décision.




[13] *https://www.samedical.org/images/attachments/guideline-on-informed-consent-jul012.pdf*

## 5.2 Formation des professionnels de santé

Pour concevoir un programme de formation efficace destiné aux professionnels de santé, vous devrez mettre en œuvre une approche multidimensionnelle combinant des informations précises, des études de cas réels et des activités d'apprentissage interactives.

Importance d'un programme médical structuré sur les questions liées à l'intersexualité

- **Il comble des lacunes importantes en matière de connaissances:** une formation spécifique à l'intersexualité aide les futurs professionnels de santé à comprendre les aspects biologiques, psychologiques et sociaux des variations intersexuées, corrigeant ainsi les idées fausses et les mythes médicaux qui persistent depuis longtemps.

- **Il encourage une approche éthique et fondée sur les droits:** une formation sur le consentement éclairé et l'autonomie corporelle garantit que les professionnels de santé respectent les droits des personnes intersexuées, en particulier en évitant les interventions irréversibles et non consenties sur les mineurs.

- **Il améliore la communication et favorise l'utilisation d'un langage inclusif dans les centres de soins:** l'enseignement d'une terminologie inclusive et non stigmatisante contribue à réduire les préjugés et la discrimination, permettant aux patients intersexués de se sentir en sécurité, considérés et respectés.

- La formation permet aux professionnels de santé de reconnaître et de répondre aux impacts émotionnels de la stigmatisation et des traumatismes médicaux, en intégrant un soutien psychologique dans les soins prodigués aux patients.

- La formation permet aux professionnels de santé de fournir des soins à la fois sensibles aux valeurs locales et fondés sur les droits humains, en particulier dans un contexte culturel et religieux.

- Elle encourage la collaboration interdisciplinaire dans la prestation de soins de santé aux personnes intersexuées, notamment les services de psychologues, d'organisations de défense des droits humains des personnes intersexuées, d'urologues, de conseillers, etc. Cela favorise une approche holistique des soins en abordant toutes les dimensions de la santé des personnes intersexuées.

- L'éducation et la formation aident les professionnels de santé à prendre des décisions délicates concernant les nourrissons et les adolescents intersexués, ce qui renforce leur esprit critique et leur responsabilité.

## 5.3 Confidentialité et vie privée

La protection de la vie privée et la confidentialité des patients sont des éléments fondamentaux du système de santé. La protection des informations intimes qui vous sont confiées en tant que professionnels de santé fait partie intégrante de votre travail et de vos responsabilités.

Mais dans un monde de plus en plus numérique, comment les prestataires de soins de santé peuvent-ils être sûrs de protéger correctement les informations des patients à tout moment ? Cette question préoccupe de plus en plus les patients intersexués et leurs familles. À l'ère numérique, il est également plus que jamais nécessaire de relier les différentes parties du système de santé afin de créer une expérience fluide tant pour les médecins que pour les patients.

Alors, comment pouvons-nous garantir la sécurité des informations dans l'environnement médical moderne?

**Garantir la confidentialité des dossiers et des communications des patients.**

**1. Créer des politiques et des accords de confidentialité rigoureux.**

L'élaboration d'accords ou de politiques de confidentialité exhaustifs et de grande envergure permet à tous les membres de votre équipe médicale de savoir exactement ce que l'on attend d'eux en toutes circonstances.

**2. Organiser des formations régulières.**

L'organisation de sessions de formation régulières pour tous les membres de votre personnel, des administrateurs aux médecins et infirmières, permet de renforcer l'importance des exigences en matière de confidentialité et de rappeler au personnel ses devoirs et les attentes à son égard.

**3. Veiller à ce que toutes les informations soient stockées sur des systèmes sécurisés**

Il est essentiel d'utiliser le plus haut niveau de sécurité et de protection numérique pour le stockage des données des patients. L'achat de plateformes ou le recours à des fournisseurs de services cloud qui garantissent la sécurité de vos données est le meilleur moyen d'y parvenir.

En outre, il est important que seul le personnel strictement nécessaire ait accès à ces données. Il convient également d'envisager et d'investir dans des niveaux de protection par mot de passe qui contrôlent l'accès.

**4. Pas de téléphones portables**

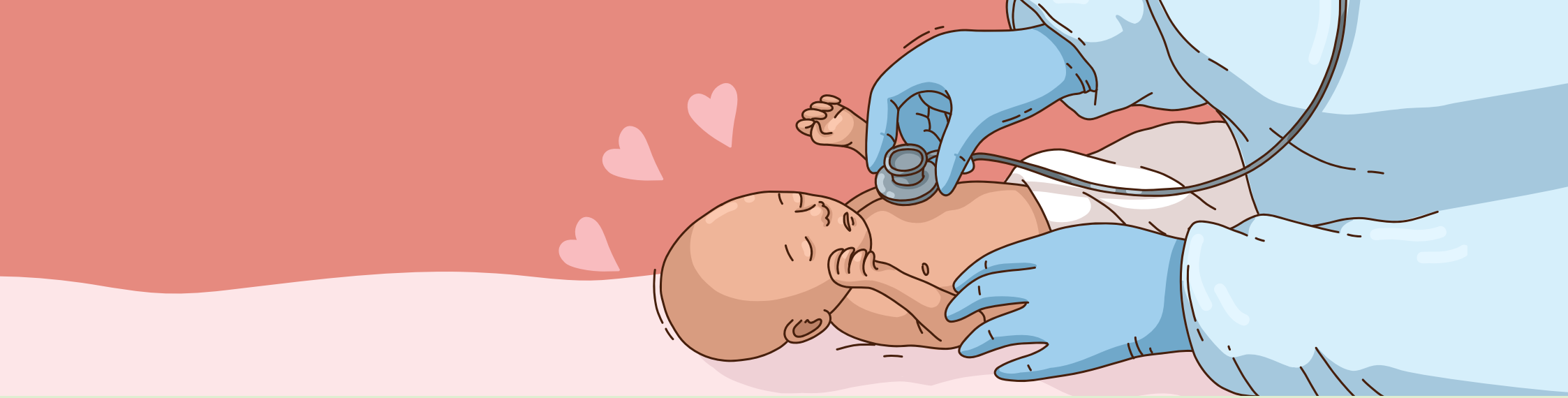
Un moyen simple d'éliminer les menaces potentielles pour la confidentialité des patients consiste à limiter strictement ou à supprimer les téléphones portables dans les zones réservées aux patients. Cela permet de s'assurer que personne ne puisse enregistrer ou photographier, de manière malveillante ou accidentelle, des dossiers ou des informations privés. Selon une étude menée par l'Imperial College Healthcare NHS Trust à Londres, 65 % des médecins utilisaient les SMS pour communiquer avec leurs collègues au sujet d'un patient, ce qui soulève des inquiétudes en matière de confidentialité [14].

Cette règle peut parfois être difficile à appliquer compte tenu de la prolifération des appareils numériques. Cependant, rappeler régulièrement au personnel et aux patients pourquoi cela est dans leur intérêt peut contribuer à réduire toute résistance.

**5. Pensez à l'impression**

Une fois que toutes vos solutions techniques et votre sécurité sont en place, il peut être tentant de penser que tout est réglé. Cependant, les documents imprimés contenant des informations clés sur les patients sont souvent négligés. Les étiquettes, les formulaires et les notes imprimées peuvent facilement être égarés, voire volés, s'ils se trouvent dans une zone très fréquentée. Il vaut la peine d'investir dans des systèmes d'impression rationalisés, faciles à utiliser et sécurisés.

[14] *https://www.samedical.org/images/attachments/guideline-on-informed-consent-jul012.pdf*



## 5.4 OBLIGATIONS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES PATIENTS

La confiance est un élément fondamental de la relation entre le prestataire de soins de santé et le patient, et l'établissement d'une relation de confiance permet de garantir que les patients divulguent des informations précises et complètes sur leur santé aux médecins et autres membres du personnel de santé. En retour, les prestataires de soins de santé et les membres du personnel ont la responsabilité éthique et juridique de protéger la confidentialité des patients et d'empêcher la divulgation non autorisée des informations médicales protégées (PHI) des patients [15].

Les lois fédérales et celles des États traitent de la confidentialité des patients et de la divulgation des informations médicales. Certaines lois des États sont plus spécifiques que les lois fédérales sur certains aspects de la confidentialité, bien qu'il n'y en ait aucune qui concerne spécifiquement les personnes intersexuées, mais la loi sur les droits de l'enfant (CRA) couvre les enfants. Les prestataires de soins de santé et les membres du personnel doivent comprendre ces exigences légales et leur rôle dans le respect des lois existantes.

**Agir dans le respect de la loi**

1. Les médecins, comme tout un chacun, doivent respecter la loi lorsqu'ils utilisent, consultent ou divulguent des informations personnelles. La législation régissant l'utilisation et la divulgation des informations personnelles est complexe et varie d'une région à l'autre du Nigeria.

[15] *https://www.medpro.com/protecting-patient- confidentiality#:~:text=In%20turn%2C%20healthcare%20providers%20and,and%20release%20of%20health%20information.*

- **Loi sur les praticiens médicaux et dentaires:** cette loi régit la pratique de la médecine et de la dentisterie au Nigeria. Elle exige des prestataires de soins de santé qu'ils préservent la confidentialité des patients et ne divulguent des informations qu'avec le consentement du patient, sauf dans les cas où la loi impose une obligation de signalement (par exemple, en cas d'urgence de santé publique). Les patients intersexués bénéficient des mêmes protections en vertu de cette loi.

- **Loi sur les droits de l'enfant (pour les mineurs):** pour les mineurs intersexués, la loi nigériane sur les droits de l'enfant définit les protections de la vie privée de l'enfant, y compris les informations médicales. Cependant, les parents ou tuteurs sont souvent impliqués dans le processus décisionnel pour les mineurs. Il est essentiel que les prestataires de soins de santé veillent à ce que la vie privée soit toujours respectée, en particulier en ce qui concerne le moment et la manière dont les informations sensibles sont partagées.

- **Règlement nigérian sur la protection des données (NDPR):** le NDPR, mis en œuvre par l'Agence nationale pour le développement des technologies de l'information (NITDA), établit des lignes directrices pour la protection des données personnelles au Nigeria. Bien qu'il ne soit pas spécifique aux soins de santé, il s'applique à toutes les informations personnelles, y compris les données médicales. Ce règlement impose que les données des individus, y compris les dossiers médicaux, soient traitées et stockées de manière sécurisée et utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

- **Lois sur la confidentialité des patients:** bien qu'il n'existe aucune loi explicitement axée sur les personnes intersexuées, les lois générales sur la confidentialité des patients au Nigeria exigent des prestataires de soins de santé qu'ils préservent la confidentialité de tous les dossiers médicaux. Ces lois empêchent la divulgation non autorisée d'informations sur les patients à des tiers sans le consentement explicite du patient.

- **Protection des données dans les systèmes de santé:** en vertu du NDPR, les établissements de santé doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité strictes pour protéger les données des patients contre tout accès non autorisé. Cela inclut l'utilisation de systèmes sécurisés de dossiers médicaux électroniques et la garantie que seul le personnel autorisé peut accéder aux informations médicales sensibles.

- **Code de déontologie médicale au Nigeria:** le Conseil médical et dentaire du Nigeria (MDCN) fournit des lignes directrices qui définissent le devoir des prestataires de soins de santé de préserver la confidentialité des patients. Le non-respect de ces lignes directrices peut entraîner des mesures disciplinaires, notamment la suspension ou la révocation d'une licence médicale.

- **Droits des patients en vertu de la loi nigériane:** la loi nigériane défend le droit des patients, y compris des personnes intersexuées, à prendre des décisions concernant leur propre corps et leurs soins de santé. Ces droits sont protégés par les lois générales sur la santé et la vie privée, qui obligent les professionnels de santé à veiller à ce que les choix médicaux des individus soient respectés et protégés du regard du public.

- **Tutelle légale et vie privée des mineurs:** pour les mineurs, la loi sur les droits de l'enfant prévoit que les parents ou tuteurs ont la responsabilité légale de prendre des décisions dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, le prestataire de soins de santé doit s'assurer que les décisions sont prises dans le respect de la vie privée et de l'autonomie future de l'enfant.

- **Recours en cas de violation de la vie privée:** en vertu de la législation nigériane, les personnes intersexuées dont la vie privée a été violée peuvent exercer un recours juridique. Les plaintes peuvent être déposées auprès du Conseil médical et dentaire nigérian pour faute professionnelle ou en vertu du NDPR pour violation de la confidentialité des données. Les prestataires de soins de santé reconnus coupables d'avoir violé leurs obligations en matière de confidentialité peuvent faire l'objet de sanctions juridiques, notamment des amendes ou la perte de leur licence professionnelle.

2. Si vous n'êtes pas sûr de la manière dont la loi s'applique dans une situation particulière, vous devez consulter un responsable de la protection des données, un délégué à la protection des données, votre organisme de défense ou votre association professionnelle, ou demander un avis juridique indépendant.

**Pourquoi des politiques inclusives et des procédures opérationnelles standardisées pour les soins de santé aux personnes intersexuées au Nigeria sont-elles essentielles?**

1. **Protection des droits humains:** des politiques inclusives fondées sur les cadres des droits humains sont essentielles pour protéger l'autonomie corporelle des personnes intersexuées au Nigeria, car elles garantissent qu'aucune intervention médicale n'est effectuée sans le consentement plein, éclairé et personnel de la personne concernée, ce qui aligne la pratique nationale sur les normes mondiales telles que les Principes de Yogyakarta[16].

2. **Interdiction de la discrimination et garantie d'un accès égal:** l'inclusion explicite de clauses anti-discrimination dans les lois sur les soins de santé et la formation des professionnels à traiter toutes les personnes avec respect et dignité garantissent que les personnes intersexuées ne se voient pas refuser l'accès aux soins en raison de leurs caractéristiques sexuelles.

3. **Traiter les dommages psychologiques grâce à des soins tenant compte des traumatismes:** les politiques de santé inclusives adoptent des pratiques de soins tenant compte des traumatismes afin d'offrir des environnements axés sur la guérison et non traumatisants.

[16] *https://en.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta_Principles*

4. **Promouvoir la reconnaissance juridique et l'autonomie des genres:** les politiques de santé inclusives s'appuient sur des cadres juridiques qui permettent aux personnes intersexuées de s'identifier elles-mêmes et d'accéder à une reconnaissance juridique sans subir de procédures invasives. La création de voies juridiques favorables garantit que les systèmes de santé respectent et affirment la diversité des genres, renforçant ainsi la dignité et la liberté d'identité.

5. **Faciliter l'accès à la justice et à la réparation:** lorsque les droits sont violés, notamment par des opérations chirurgicales non consenties ou le refus de soins, une politique inclusive établira les modalités d'accès à la justice pour les personnes intersexuées. Les politiques de santé doivent inclure des mécanismes de réparation juridique, d'indemnisation et de responsabilité. De telles dispositions renforcent la confiance du public dans le système de santé et affirment que les violations à l'encontre des personnes intersexuées ne seront ni tolérées ni ignorées par la loi nigériane.

# 6.0

# Compétence Et Sensibilité Culturelles



# 6.0 Compétence Et Sensibilité Culturelles

## 6.1 Comprendre la diversité culturelle et son impact sur les soins de santé destinés aux personnes intersexuées

Le Nigeria présente une grande diversité culturelle, avec plus de 250 groupes ethniques et un large éventail de pratiques religieuses, qui ont fortement influencé les opinions de la société sur le genre, l'identité et la santé. Cette diversité est essentielle pour comprendre les défis et les obstacles auxquels sont confrontées les personnes intersexuées dans le domaine des soins de santé dans le pays. Dans une société où les normes traditionnelles de genre sont profondément ancrées dans les croyances culturelles et religieuses, les personnes intersexuées dont les caractéristiques physiques ne correspondent pas aux définitions conventionnelles de l'homme ou de la femme sont souvent victimes de stigmatisation sociale et de marginalisation. Pour les prestataires de soins de santé, naviguer dans ce paysage culturel nécessite de la sensibilité, du respect pour les traditions locales et un engagement en faveur de soins centrés sur le patient qui protègent la dignité et les droits des personnes intersexuées.

La diversité culturelle influence considérablement les soins de santé destinés aux personnes intersexuées au Nigeria, notamment en raison des normes de genre rigides, des croyances religieuses et des pratiques traditionnelles. Les personnes intersexuées sont souvent soumises à une pression intense de la part de leur famille et de leur communauté pour se conformer aux rôles de genre binaires par le biais d'interventions médicales précoces. La religion, en particulier le christianisme et l'islam, renforce ces visions binaires et influence les décisions familiales, ce qui est souvent en contradiction avec les normes médicales et les droits humains modernes. Les croyances traditionnelles liées à des rôles tels que le mariage et la fertilité poussent encore davantage à recourir à des procédures médicales inutiles, en particulier dans les zones rurales.

Les professionnels de santé peuvent également avoir des préjugés culturels ou religieux, ce qui conduit à des discriminations, à des traitements insensibles ou au refus de soins. Pour remédier à ces problèmes, les professionnels de santé doivent suivre une formation appropriée sur les soins de santé aux personnes intersexuées, la communication respectueuse et la sensibilité culturelle. Pour instaurer la confiance avec les patients intersexués et leurs familles, il faut faire preuve d'empathie, fournir des informations claires et s'engager à donner la priorité aux droits, à la santé et à l'autonomie de l'individu plutôt qu'aux attentes de la société.

**Stratégies pour les professionnels de santé afin de fournir des soins adaptés à la culture des personnes intersexuées.**

La compétence culturelle est nécessaire pour fournir des soins sûrs qui éliminent la méfiance et comblent les disparités en matière de soins de santé.

- Engagez-vous dans une réflexion critique sur vos propres valeurs, attitudes et croyances.
- Recherchez des opportunités d'apprentissage liées aux soins prodigués aux communautés et aux personnes intersexuées.
- Devenez un allié des personnes intersexuées.
- Demandez à vos patients intersexués comment ils préfèrent être appelés (quel nom ils préfèrent).
- Ne faites pas de suppositions basées sur l'apparence et/ou la tenue vestimentaire.
- Faites attention au langage qui étiquette.
- Évitez les suppositions concernant l'identité de genre et les préférences sexuelles d'une personne.

- Identifiez-vous comme un prestataire de soins de santé favorable aux personnes intersexuées et prouvez-le en démontrant votre connaissance des droits des personnes intersexuées.
- Créez un environnement accueillant en affichant une charte des droits des patients et une politique de non-discrimination inclusive envers les personnes intersexuées dans votre établissement ou centre de soins de santé.
- Recueillez les commentaires des patients intersexués et de leurs familles.
- Modifiez les formulaires afin d'y inclure un langage neutre en termes de genre.
- Intégrez une formation continue sur la compétence culturelle pour l'ensemble du personnel chaque année.
- Évitez les suppositions basées sur le genre lorsque vous choisissez des vêtements d'hôpital pour les patients intersexués.
- Affichez des symboles ou des panneaux adaptés aux personnes intersexuées à des endroits où les patients peuvent les voir.
- Tenez compte des questions de confidentialité liées aux conversations entre les infirmières et les patients.
- Tenez compte des questions de confidentialité lorsque le patient se trouve dans une zone d'attente ouverte et/ou une zone d'accueil.
- Fournissez aux patients et à leur famille/leurs amis une copie de la politique relative au traitement des plaintes liées à l'intersexualité.

**Lutter contre les préjugés et favoriser un environnement de soins de santé inclusif.**

L'un des défis les plus urgents auxquels nous avons été confrontés est celui des préjugés qui existent au sein des systèmes de santé, en particulier à l'égard des personnes intersexuées. Au Nigeria, où les normes culturelles, religieuses et sociales renforcent souvent les visions binaires du sexe et du genre, les prestataires de soins de santé jouent un rôle essentiel dans la perpétuation ou la remise en question de ces normes. Malheureusement, de nombreux prestataires de soins de santé n'ont pas pleinement compris les besoins et les expériences uniques des personnes intersexuées, ce qui conduit à des traitements biaisés, à des décisions médicales mal informées et à un manque de soins inclusifs. Pour lutter contre ces préjugés et favoriser un environnement de soins de santé inclusif, des mesures délibérées sont nécessaires, notamment l'éducation, des changements de politique et un engagement en faveur de soins centrés sur le patient.

**1. Éducation et formation sur les questions liées à l'intersexualité**

Une étape importante pour lutter contre les préjugés au sein des systèmes et des établissements de santé au Nigeria consiste à fournir une éducation et une formation complètes sur les questions liées à l'intersexualité. Les prestataires de soins de santé doivent être informés de la diversité naturelle des caractéristiques intersexuées. La formation doit mettre l'accent sur la fin des pratiques médicales néfastes et non consensuelles et sur la promotion de soins éthiques et compatissants.

**2. Souligner l'importance du consentement éclairé**

Le consentement éclairé est un principe essentiel dans tous les domaines des soins de santé, mais il est particulièrement important dans le traitement des personnes intersexuées. Historiquement, de nombreuses personnes intersexuées au Nigeria et dans le monde ont été soumises à des interventions médicales sans leur consentement éclairé, souvent pendant la petite enfance ou l'enfance. Cette pratique viole non seulement l'autonomie de l'individu, mais contribue également à un traumatisme psychologique et physique qui dure toute la vie.

Les prestataires de soins de santé doivent être formés à respecter le droit des personnes intersexuées à prendre des décisions éclairées concernant leur propre corps.

**3. Créer une approche culturellement compétente et sensible**
Les prestataires de soins de santé doivent être formés à mener des conversations culturellement sensibles avec les personnes intersexuées et leurs familles. Par exemple, lorsqu'ils discutent des caractéristiques intersexuées d'un enfant, les professionnels de santé doivent éviter tout langage stigmatisant et rassurer les familles en leur expliquant que les variations intersexuées font naturellement partie de la diversité humaine. Ils doivent également être prêts à aborder les préoccupations culturelles ou religieuses avec empathie, en aidant les familles à naviguer dans ces questions complexes tout en gardant à l'esprit le bien-être de la personne intersexuée.

**4. Utiliser un langage inclusif et affirmatif**
L'un des moyens les plus efficaces pour les prestataires de soins de santé de lutter contre les préjugés consiste à adopter un langage inclusif et valorisant lorsqu'ils interagissent avec des personnes intersexuées. Le langage joue un rôle important dans la formation des attitudes et des perceptions, et l'utilisation de termes irrespectueux ou stigmatisants peut renforcer les préjugés néfastes et faire en sorte que les patients intersexués se sentent aliénés ou méprisés.

Les prestataires de soins de santé et tous les membres du personnel. Ce simple geste de respect peut grandement contribuer à faire en sorte que les patients intersexués se sentent valorisés, écoutés et soutenus.

**5. Mettre en œuvre des politiques visant à protéger les droits des personnes intersexuées**
Les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé publique doivent adopter des politiques qui protègent explicitement les droits des personnes intersexuées. Des politiques anti-discrimination qui protègent les personnes intersexuées contre les traitements discriminatoires, le harcèlement ou le refus de soins fondés sur leurs caractéristiques sexuelles doivent également être élaborées et institutionnalisées.

**6. Fournir un soutien en matière de santé mentale**
Les personnes intersexuées sont souvent confrontées à d'importants défis psychologiques liés à leur expérience de la stigmatisation, de la discrimination et de la médicalisation. Afin de créer un environnement de soins de santé véritablement inclusif, les prestataires doivent offrir un soutien complet en matière de santé mentale aux patients intersexués, en reconnaissant l'impact émotionnel et psychologique de grandir dans une société qui n'accepte pas pleinement leurs différences.

# 7.0 Études De Cas Et Meilleures Pratiques



# 7.0 Études De Cas Et Meilleures Pratiques



## 7.1 Études de cas

**Exemples concrets de pratiques de soins de santé adaptées aux personnes intersexuées.**

Les efforts de plaidoyer de Human Rights Watch[17] et plusieurs hôpitaux américains ont conduit à l'élaboration de nouvelles politiques visant à former les équipes médicales aux questions liées à l'intersexualité et à protéger les droits des patients à l'autonomie et au consentement éclairé. Dans certains cas, les hôpitaux ont également créé des formulaires d'admission adaptés aux personnes intersexuées qui reconnaissent les identités de genre non binaires ou diverses, ce qui contribue à favoriser un environnement de soins de santé plus inclusif et respectueux.

En Australie, Intersex Human Rights Australia et Intersex Peer Support Australia[18] ont mis en place des programmes communautaires permettant aux personnes intersexuées de se rencontrer et de bénéficier du soutien de leurs pairs en plus de leurs soins médicaux. Ces réseaux offrent aux personnes intersexuées un espace sûr où elles peuvent discuter de leurs expériences et accéder à des soins adaptés sans craindre la discrimination. Il a été démontré que le soutien par les pairs réduit le poids émotionnel lié au sentiment d'isolement ou d'incompréhension de la part des professionnels de santé.

Des pays comme l'Allemagne et le Chili ont adopté des lois visant à reporter les opérations chirurgicales non consenties sur les nourrissons intersexués. Ce changement est intervenu après des années de plaidoyer de la part d'organisations de défense des droits des personnes intersexuées et de recherches montrant les dommages causés par les opérations chirurgicales précoces visant à « normaliser » l'apparence des organes génitaux. Ces lois donnent aux personnes intersexuées le temps de grandir et de décider elles-mêmes si elles souhaitent subir des interventions médicales, favorisant ainsi une approche plus éthique des soins de santé destinés aux personnes intersexuées.[19]

Des prestataires de soins de santé tels que ceux du Boston Children's Hospital et de l'université du Michigan ont adopté des modèles multidisciplinaires pour les soins aux personnes intersexuées[20]. Ces équipes sont composées d'endocrinologues, d'urologues, de psychologues, de travailleurs sociaux et d'éthiciens qui travaillent ensemble pour garantir que les patients intersexués reçoivent des soins complets qui répondent à leurs besoins physiques et émotionnels. Ces institutions soulignent l'importance de la prise de décision partagée, dans le cadre de laquelle les patients et leurs familles reçoivent toutes les informations pertinentes avant de prendre des décisions en matière de soins de santé.

Howard Brown Health, à Chicago, intègre des services de santé mentale dans son modèle de soins aux patients intersexués . Conscient des répercussions psychologiques de la stigmatisation et des traumatismes médicaux, Howard Brown propose des services de conseil et de soutien par les pairs aux personnes intersexuées et à leurs familles. Cette approche holistique garantit que les soins de santé ne traitent pas seulement les problèmes médicaux, mais aussi les difficultés émotionnelles et sociales liées à l'intersexualité.

## 7.2 Bonnes pratiques - Exemples de réussite de pays défendant la santé et les droits des personnes intersexuées.

### Afrique du Sud



En Afrique du Sud, en vertu de l'article 2 de la loi de 2003 sur la modification de la description du sexe, les personnes intersexuées peuvent modifier leur nom et leur sexe sur leur certificat de naissance afin de correspondre au genre qu'elles préfèrent. La loi de 2004 sur la promotion de l'égalité et la prévention de la discrimination injuste interprète la définition du terme « sexe » comme incluant les personnes intersexuées ; par conséquent, les personnes intersexuées sont également protégées contre la discrimination fondée sur le sexe.[22]

### Kenya



L'article 10(3) de la loi de 2014 sur les personnes privées de liberté au Kenya accorde aux personnes intersexuées privées de liberté le droit de déterminer leur genre lors d'une fouille corporelle, reconnaissant ainsi l'autonomie corporelle dans un contexte où les individus sont particulièrement vulnérables[23]. En 2019, le Kenya est entré dans l'histoire en devenant le premier pays africain à recenser les personnes intersexuées dans son recensement national en introduisant un marqueur de sexe « I » - une étape importante qui confirme la reconnaissance juridique et permet l'inclusion dans la planification nationale[24]. La société civile a joué un rôle déterminant dans ces progrès : l'Intersex Persons Society of Kenya (IPSK), Jinsiangu et d'autres organisations ont mené des campagnes de sensibilisation, engagé des actions politiques et apporté leur soutien à la communauté, tandis que la KNCHR a activement défendu la réforme, notamment par le biais de consultations publiques et de la rédaction du projet de loi sur les personnes intersexuées.

[17] *https://ihra.org.au/inclusion/*
[18] *Intersex Human Rights Australia*
[19] *https://www.hrw.org/report/2017/10/26/changing-paradigm/us-medical-provider-discomfort-intersex-care-practices*
[20] *https://www.hrw.org/report/2017/10/26/changing-paradigm/us-medical-provider-discomfort-intersex-care-practices*
[21] *https://howardbrown.org/supporting-intersex-identities-in-healthcare/*
[22] *https://www.chr.up.ac.za/the-intersex-project*
[23] *https://klrc.go.ke/index.php/projects/on-going-projects/612-taskforce-on-policy-legal-institutional-and-administrative-reforms-regarding-intersex-persons-in-kenya*

### Malte

Malte est devenu le premier pays à interdire les interventions médicales non consenties sur les enfants intersexués en 2015, créant un précédent en matière de protection juridique avec la loi sur l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles (2015). Celle-ci interdit non seulement les interventions médicales non consenties sur les personnes intersexuées, mais offre également des voies de recours juridiques aux personnes dont les droits ont été violés. Cela inclut le droit à une indemnisation pour les dommages physiques ou psychologiques résultant de telles interventions[25].

**Autres cadres internationaux:** Outre ce qui précède, certains cadres internationaux ont reconnu et exigé la protection des personnes intersexuées. Parmi ces cadres figurent la résolution 55/14 du Comité des droits de l'homme des Nations unies (adoptée en avril 2024)[26] qui appelle tous les États à lutter contre la discrimination, la violence et les pratiques néfastes à l'égard des personnes intersexuées ; et la résolution 552 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) (adoptée en mars 2023)[27] qui exhorte à la promotion et à la protection des droits des personnes intersexuées à travers l'Afrique.

### Islande

Intersex Ísland, fondée en 2014 afin d'offrir un espace sûr aux personnes intersexuées, d'éduquer le public sur les questions liées à l'intersexualité et de défendre les droits des personnes intersexuées, a travaillé avec une équipe d'experts linguistiques afin de développer une base linguistique de terminologie intersexuée non pathologisante. Grâce à l'éducation du public et au plaidoyer politique, Intersex Ísland a façonné un discours alternatif autour de l'intersexualité en langue islandaise. En très peu de temps, l'organisation a réussi à mobiliser les partis politiques, les parlementaires et les principaux ministres du gouvernement islandais, dont certains se sont publiquement prononcés contre les opérations chirurgicales non consenties sur les enfants intersexués. Grâce aux efforts d'Intersex Ísland, des informations sur l'intersexualité sont désormais incluses dans les supports pédagogiques distribués à toutes les écoles de la région de Reykjavik et accessibles à toutes les écoles du pays.[28]

[24] *https://rightsafrica.com/2022/10/28/kenya-passes-landmark-law-to-recognize-and-protect-intersex-people/*
[25] *https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/*
[26] *https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/55/14*
[27] *https://achpr.au.int/en/adopted-resolutions/resolution-promotion-and-protection-rights-intersex-persons/*
[28] *https://www.arcusfoundation.org/wp-content/uploads/2016/08/AstraeaWeAreRealReport2.pdf*

### Australie



L'Australie est reconnue comme un leader en matière de droits à la santé des personnes intersexuées, combinant protections juridiques, réforme politique et défense des droits par les pairs. La loi de 2013 modifiant la loi sur la discrimination sexuelle a fait du « statut intersexué » une caractéristique protégée, interdisant la discrimination dans l'emploi, l'éducation et les services[29] . Suite aux recommandations de la Commission australienne des droits de l'homme (2021), le Territoire de la capitale australienne a adopté la loi de 2023 sur la variation des caractéristiques sexuelles (traitement médical restreint), première loi en Australie à interdire les interventions médicales non consenties sur les mineurs intersexués, à garantir la surveillance et à fournir un soutien psychosocial.[30]

### Grèce



La Grèce a fait des progrès significatifs dans la promotion de la santé et des droits humains des personnes intersexuées grâce à une législation historique et à l'élaboration de politiques inclusives. Lors d'un vote historique le 19 juillet 2022, le Parlement grec a adopté la loi sur la réforme de la procréation médicalement assistée (loi 4958/2022), qui interdit les interventions chirurgicales et hormonales non consenties sur les mineurs intersexués de moins de 15 ans, sauf en cas d'absolue nécessité, d'autorisation judiciaire et d'avis interdisciplinaire d'experts, et qui prévoit des sanctions sévères en cas de violation, notamment des amendes, des peines d'emprisonnement et des interdictions d'exercer pour les praticiens médicaux[31]. En outre, la loi grecque 5029 de 2023 sur la protection contre la violence et le harcèlement inclut les « caractéristiques sexuelles » parmi les motifs protégés dans le milieu scolaire, renforçant ainsi les protections juridiques contre la discrimination à l'égard des personnes intersexuées.[32]

[29] *https://www5.austlii.edu.au/au/legis/cth/bill_em/sdaogiaisb2013865/memo_0.html*
[30] *https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/commission-welcomes-passage-new-act-intersex-laws*
[31] *https://www.oiieurope.org/greek-parliament-votes-to-ban-igm/*
[32] *https://www.oiieurope.org/good-practice-map-2023/*

# 8.0 Appel À L'action



# 8.0 Appel À L'action

**1. Retarder les interventions chirurgicales précoces**

De plus en plus d'études soutiennent l'idée de retarder les interventions chirurgicales médicalement inutiles sur les nourrissons et les enfants intersexués jusqu'à ce qu'ils puissent participer à la prise de décision. Des études montrent que les chirurgies génitales précoces peuvent entraîner des dommages physiques et psychologiques, en particulier lorsqu'elles ne correspondent pas à l'identité de genre de la personne plus tard dans sa vie.
Cette tendance va dans le sens des recommandations de groupes de défense tels que Human Rights Watch et interACT, qui promeuvent l'autonomie des patients.

**2. Se concentrer sur la santé hormonale et le suivi à long terme**

De nouvelles recherches soulignent l'importance de la gestion hormonale pour les personnes intersexuées, en particulier celles qui ont subi une gonadectomie (ablation des gonades). Par exemple, les personnes atteintes de syndromes tels que le syndrome d'insensibilité complète aux androgènes (CAIS) peuvent avoir besoin d'un traitement hormonal substitutif à vie pour maintenir leur santé osseuse et gérer d'autres effets secondaires liés à leur variation intersexuée.
Les recherches soulignent également la nécessité de meilleures directives en matière de soins à long terme afin de traiter des problèmes tels que la santé métabolique, la fertilité et les risques de cancer associés à certaines variations intersexuées.

**3. Santé mentale et soutien psychosocial**

La recherche sur la santé mentale gagne du terrain, avec des études axées sur les impacts sociaux et émotionnels des variations intersexuées. De nombreuses personnes intersexuées sont victimes de stigmatisation, d'isolement social ou de traumatismes liés à des interventions médicales. Des institutions telles que Howard Brown Health intègrent des services de santé mentale dans leurs offres de soins de santé intersexués, reconnaissant que des soins holistiques, y compris l'accès à des groupes de soutien et à des services de conseil, sont essentiels.

**4. Modèles de soins centrés sur le patient**

La recherche explore également les avantages des modèles de soins multidisciplinaires pour les patients intersexués, impliquant des endocrinologues, des urologues, des professionnels de la santé mentale et des travailleurs sociaux. Cette approche vise à fournir des soins complets qui vont au-delà des besoins immédiats en matière de santé physique. Dans des pays comme l'Australie, des organisations telles que Intersex Human Rights Australia sont à l'avant-garde de l'élaboration de cadres de soins inclusifs qui accordent la priorité à l'autonomie des patients et au consentement éclairé.

### 5. Collecte de données et lacunes dans la recherche

Une autre tendance consiste à réclamer une meilleure collecte de données sur les populations intersexuées. Les chercheurs et les défenseurs soulignent la nécessité d'améliorer les dossiers médicaux, de standardiser la collecte de données sur les résultats en matière de santé et d'utiliser des formulaires d'admission inclusifs qui reflètent la diversité des expériences intersexuées[33]. Ces efforts visent à combler les lacunes en matière de recherche et à améliorer les soins fondés sur des preuves, en particulier dans des domaines tels que le conseil en matière de fertilité, la prévention du cancer et la surveillance à long terme de la santé.

### 6. Recherche sur le cancer et la fertilité'

De nouvelles recherches se penchent sur les risques accrus de cancer associés à certaines variations intersexuées, en particulier celles impliquant des genres atypiques. Par exemple, les personnes atteintes du syndrome de Swyer ou d'autres variations DSD peuvent présenter un risque plus élevé de développer des tumeurs germinales si leurs gonades ne sont pas retirées. Les options de fertilité pour les personnes intersexuées, telles que l'extraction de sperme testiculaire ou la fécondation in vitro (FIV), suscitent également un intérêt clinique croissant, même si d'importantes lacunes subsistent dans les connaissances.

### 7. Changements politiques et défense des droits

Au niveau politique, des organisations telles que l'American Medical Association et l'American Academy of Paediatrics sont en train de revoir leurs directives en réponse à la pression exercée par des groupes de défense des droits. Ces groupes réclament un moratoire sur les interventions chirurgicales qui ne sont pas médicalement nécessaires jusqu'à ce que le patient puisse participer de manière significative aux décisions. HRW
Ce changement reflète une tendance plus large à aligner les pratiques médicales sur les cadres des droits humains.

[33] *https://www.oiieurope.org/good-practice-map-2023*

# Conclusion



## Résumé du contenu de la boîte à outils.

Cette boîte à outils pour des soins de santé adaptés aux personnes intersexuées est conçue comme une ressource complète destinée aux prestataires de soins de santé, aux décideurs politiques et aux responsables communautaires afin d'améliorer la prestation des soins de santé aux personnes intersexuées.

**La boîte à outils répond à plusieurs objectifs clés:**

1. **Éducation et sensibilisation:** elle vise à sensibiliser les professionnels de la santé aux variations intersexuées et à éliminer les pratiques médicales obsolètes qui privilégient la normalisation du corps au détriment de l'autonomie du patient. La boîte à outils souligne la nécessité pour les systèmes de santé d'évoluer vers une reconnaissance de la diversité corporelle comme étant naturelle et d'éviter les interventions médicales inutiles.

2. **Interventions médicales éthiques:** la boîte à outils promeut des soins centrés sur le patient, en mettant fortement l'accent sur le consentement éclairé, l'autonomie corporelle et le report des interventions médicales non urgentes, en particulier les chirurgies non urgentes sur les nourrissons intersexués.

3. **Compétence culturelle:** il est essentiel de comprendre le contexte culturel, en particulier dans des régions comme le Nigeria. La boîte à outils propose des stratégies pour interagir avec les patients et leurs familles de manière respectueuse, en accord avec les valeurs culturelles et les droits humains.

4. **Défense des droits et autonomisation:** elle fournit aux personnes intersexuées et à leurs familles les outils nécessaires pour défendre leurs droits dans le cadre des soins de santé. L'accent est mis sur la promotion de l'autonomie sociale, le soutien en matière de santé mentale et la création d'environnements respectueux des identités intersexuées.

5. **Élaboration de politiques:** la boîte à outils souligne également l'importance et la nécessité d'un cadre politique inclusif et complet pour les soins de santé aux personnes intersexuées.

6. **Consentement éclairé et pratique éthique:** l'accent est mis sur le respect des normes éthiques, en particulier en ce qui concerne le consentement éclairé, et sur la garantie que les décisions médicales sont prises avec la pleine participation du patient ou de ses tuteurs. La boîte à outils souligne que toute intervention médicale doit respecter l'autonomie corporelle des personnes intersexuées.

7. **Formation et soutien:** la boîte à outils préconise la mise en place de programmes de formation continue pour les prestataires de soins de santé, afin d'améliorer leur compréhension des questions liées à l'intersexualité et de les préparer à fournir des soins non discriminatoires. Elle encourage également le soutien institutionnel afin de créer un environnement de soins de santé inclusif pour les personnes intersexuées.

8. **Ressources et outils:** enfin, la boîte à outils propose des ressources, notamment des études de cas, des bonnes pratiques et des modèles, afin d'aider les prestataires de soins de santé à mettre en œuvre des politiques et des pratiques inclusives pour les personnes intersexuées.



intersex
NIGERIA

Ce document a été élaboré et publié par Intersex Nigeria